



Gravidez na Adolescência

Fenômeno complexo e multicausal

2022

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO – SEP
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IJSN



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: Fenômeno complexo e multicausal

Vitória, fevereiro 2022

Instituto Jones dos Santos Neves
Gravidez na Adolescência: Fenômeno complexo e
multicausal.

Vitória, ES, 2022. 64 p.; il. tab. (Cadernos da
Juventude | 09)

1. Gravidez Precoce. 2. Adolescência. 3. Espírito Santo.

I. Gonçalves, Thalita Matias. II. Título. III. Série.

*As opiniões emitidas são exclusivas e de inteira responsabilidade do (os) autor (es), não exprimindo necessariamente, o ponto de vista do Instituto Jones dos Santos Neves ou da Secretária de Estado de Economia e Planejamento do governo do Estado do Espírito Santo.



GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

José Renato Casagrande

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Jacqueline Moraes

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Gilson Daniel Batista

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Diretor Presidente

Daniel Ricardo do Castro Cerqueira

Diretoria de Estudos e Pesquisas

Latussa Laranja Monteiro

Diretoria de Integração e Projetos Especiais

Pablo Silva Lira

Gerência Administrativa e Financeira

Gustavo Ribeiro

Coordenação de Estudos Sociais

Sandra Mara Pereira

Execução Técnica

Compilação de dados
Coordenação de Estatística

Elaboração
Thalita Matias Gonçalves
Coordenação de Estudos Sociais

Revisão
Sandra Mara Pereira

Assessoria de Relacionamento Institucional

Projeto Gráfico
Lastênio João Scopel

Editoração
Eugênio Herkenhoff

Bibliotecário
Jair Rosário Filho

Fotografias
Pixabay.com

APRESENTAÇÃO

O caderno da Juventude é uma publicação periódica do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) que tem como objetivo contribuir para a reflexão sobre as juventudes no estado do Espírito Santo.

A nona edição do Caderno da Juventude visa contribuir para o debate sobre o fenômeno da gravidez na adolescência. Para tanto, o texto traz uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto e temas correspondentes, como o casamento precoce e a violência sexual. Além disso, apresenta os dados que elucidam os aspectos da temática no estado do Espírito Santo (ES) e, quando necessário, no Brasil e na Região Sudeste.

Este texto está estruturado em 05 seções, além da introdução e das considerações finais. Na primeira seção pretende-se debater acerca da gravidez na adolescência enquanto acontecimento complexo e multicausal, elencando parte das problematizações que a literatura sobre a temática tem demonstrado. A segunda parte traz apontamentos sobre o casamento precoce. Em seguida, busca-se discutir sobre as particularidades das gravidezes das meninas de 10 a 14 anos de idade, compreendidas como oriundas de violência sexual. A quarta seção visa apresentar os dados referentes às gravidezes das adolescentes no Brasil, Sudeste e ES. A quinta parte ocupa-se em debater sobre os obstáculos para o enfrentamento da gravidez precoce e sinalizar perspectivas que possam colaborar para mitigar o fenômeno.

Boa leitura!

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1.Introdução	9
2. Gravidez na Adolescência: fenômeno complexo e multifacetado	16
2.1. Adolescência e Sexualidade: alguns apontamentos	17
2.2. Gravidez na Adolescência enquanto um problema de saúde pública	19
2.3. Dimensões sócio-culturais vinculadas ao desejo de ser mãe	20
3. Casamento em idade precoce e direitos sexuais e reprodutivos: uma realidade que não pode ser ignorada	23
4. Gravidezes de meninas de 10 a 14 anos: discussão sobre violência sexual	26
5. Cenário da Gravidez Precoce no Brasil, Sudeste e ES	32
5.1. Perfil das mães adolescentes	43
5.2. Desafios e Perspectivas	50
Considerações Finais	53
Referências	55
Anexos	58

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01 – Percentual de adolescentes (10 a 19 anos), Brasil, Sudeste e ES, 2019 (%)	13
Gráfico 02 – Percentual de adolescentes (10 a 19 anos), por faixa etária, ES, 2019 (%)	13
Gráfico 03 – Adolescentes (10 a 19 anos), por raça/cor, Espírito Santo, 2019 (%)	14
Gráfico 04 – Frequência escolar, adolescentes (10 a 19 anos), ES, 2019 (%)	14
Gráfico 05 – Adolescentes (10 a 19 anos) que não frequentam a escola, por raça/cor, ES, 2019 (%)	15
Gráfico 06 – Número de casamentos de crianças e adolescentes do sexo feminino, Espírito Santo, 2010-2019	25
Gráfico 07 – Notificação de estupro contra crianças e adolescentes, por faixa etária, Espírito Santo, 2012-2019	30
Gráfico 08 – Notificação de estupro contra menores de 19 anos de idade, por sexo, Espírito Santo, 2012-2019	30
Gráfico 09 – Notificação de estupro contra menores de 19 anos de idade, por raça/cor, Espírito Santo, 2012-2019	31
Gráfico 10 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Brasil, Sudeste e ES, 2010-2019 (%)	33
Gráfico 11 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Regiões do Brasil, 2010-2019 (%)	34
Gráfico 12 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Regiões da Saúde do ES, Espírito Santo, 2010-2019 (%)	35
Gráfico 13 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), ES, regiões da saúde- ES, 2019 (%)	35
Gráfico 14 – Percentual de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, Brasil, Sudeste e Espírito Santo, 2010-2019 (%)	36
Gráfico 15 – Número de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, ES, 2010-2020	37
Gráfico 16 – Nascidos vivos de mães adolescentes, Brasil, Sudeste e ES, por raça/cor, 2019 (%)	43
Gráfico 17 – Escolaridade das meninas mães de nascidos vivos, 10 a 14 anos, ES, 2019 (%) .	44
Gráfico 18 – Escolaridade das mães de nascidos vivos, 15 a 19 anos, ES, 2019 (%).....	44
Gráfico 19– Estado civil de mães adolescentes (10 a 19 anos) de nascidos vivos, ES, 2019 (%).....	45
Gráfico 20 – Estado civil das meninas mães, 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)	45
Gráfico 21 – Principais ocupações de mães adolescentes (10 a 19 anos) de nascidos vivos, ES, 2019 (%)	46
Gráfico 22 – Principais ocupações das meninas mães, 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)	46
Gráfico 23 – Número de atendimentos pré-natal de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos) e de mães adultas, ES, 2019 (%)	47

Gráfico 24 – Número de atendimentos pré-natal de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)	48
Gráfico 25 – Tipo de parto dos nascidos vivo de mães adolescentes, por faixa etária, ES, 2019 (%)	49
Gráfico 26 – Tipo de parto dos nascidos vivo de mães adolescentes, Brasil, Sudeste e ES, 2019 (%)	49

LISTA DE MAPAS

Mapa 01- Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Municípios do ES, 2019 (%)	38
Mapa 02- Percentual de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2019 (%)	40
Mapa 03- Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Microrregiões do ES, 2019 (%)	42



A adolescência é um período da vida caracterizado por transformações sociais, biológicas, psicológicas, fisiológicas. O conceito e a condição de adolescência correspondem a uma construção histórica, social, cultural e relacional, ou seja, adquire sentidos diferentes de acordo com o contexto histórico vigente. E, assim como outras etapas da vida, a adolescência não é homogênea, mas se constitui a partir da diversidade econômica, racial, de gênero, sexual, religiosa, que atravessam esse segmento populacional.

De acordo com Àries (apud SALLES, 2005, p. 35) a adolescência é uma invenção própria da sociedade industrial, de modo que a especificidade desse momento da vida foi reconhecida e emergiu com a escolarização, que supõe a separação entre seres adultos e seres em formação, com a família burguesa que separa o espaço familiar do exterior e com a progressiva exclusão da criança do mundo do trabalho.

Na sociedade ocidental moderna a adolescência é compreendida como um período de transição entre a infância e a vida adulta em que a preparação para o trabalho (por meio da escolarização) e a construção da identidade são aspectos fundamentais. Contudo, entende-se que essa fase não é somente intermediária entre a infância e a vida adulta. Ainda que ocorram mudanças biológicas e fisiológicas importantes, elas têm significados diferentes conforme o tempo e o espaço.

Dessa maneira, o mero recorte biológico (transformações do organismo humano) ou demográfico (faixas etárias) é insuficiente para contemplar a ideia de adolescência. Não existe um consenso tanto na literatura quanto nos marcos normativos legais em relação à faixa etária adequada correspondente ao período em questão. A faixa etária delimitada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) compreende as pessoas entre 12 e 18 anos completos. Já para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência é o período de 10 a 19 anos de idade, faixa etária assumida neste texto.

A concepção das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, algo relativamente recente na história do Brasil, advém do ordenamento legal específico que ocorreu com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e a Convenção Internacional da Criança (1990). Tal aparato legal é reflexo da luta de movimentos sociais que defendiam pautas relacionadas aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Um fenômeno que afeta a vida de meninas e meninos adolescentes tanto em âmbito internacional, nacional e estadual é a gravidez precoce. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera gravidez precoce aquela que envolve a população com até 19 anos de idade¹. De modo geral, a gravidez neste período da vida é vista como uma experiência indesejada, uma vez que comprometeria a formação da identidade, o futuro profissional e as atividades relacionadas ao lazer. Sendo assim, a gravidez na adolescência é tida como um problema social e de saúde pública. A partir dos anos 1970 a gravidez na adolescência é classificada como gestação de alto risco pela OMS. Nessa direção, o Ministério da Saúde também adota essa premissa.

Miura, Tardivo e Barrientos (2018) sinalizaram que cerca de 7,3 milhões de jovens menores de 18 anos têm filhos anualmente, sendo que dessas estima-se que 2 milhões são de meninas menores de 15 anos. A partir da segunda metade do século XX a América Latina e o Caribe têm vivenciado uma significativa diminuição da fecundidade entre as mulheres adultas, com variações entre os países. Conquanto a fecundidade adolescente na América Latina e Caribe tenha sido reduzida nas últi-

¹ São poucos os casos de gestações de meninas menores de 10 anos. Por isso o enfoque do texto é nas faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. No período de 2010 a 2019 no Brasil, 12 meninas com menos de 10 anos de idade foram mães. No estado do Espírito Santo (ES) não houve nenhum caso registrado de meninas com menos de 10 anos de idade que foram mães no período mencionado.

mas décadas, ainda continua sendo alta quando comparada com a média mundial e as outras regiões.

Segundo o relatório sobre a Situação da População Mundial, divulgado no ano de 2020 pelo Fundo da População da Organização das Nações Unidas (ONU), a cada mil adolescentes no Brasil cerca de 53 engravidaram de forma precoce. Esse índice obteve uma significativa melhora em relação ao ano de 2019, em que a taxa era de 62 gravidezes precoces a cada mil adolescentes. Contudo, a média do país ainda está acima da taxa mundial que é de 41 para cada mil.

A fecundidade na adolescência é um fenômeno complexo e multifacetado vinculado aos aspectos sociais, históricos e psicológicos. A gestação precoce é considerada pela OMS e por vários estudiosos um problema de saúde pública, além de um fator basilar para a reprodução do ciclo de pobreza. Esse evento suscita efeitos econômicos, psíquicos e sociais, conforme argumenta Santos e Nogueira (2019). Sociais porque, geralmente, as meninas abandonam os estudos, psíquicas porque não estão emocionalmente estáveis para assumir uma gravidez e econômicas porque na maioria dos casos a família da adolescente assume a criança de modo que aumentam as despesas da família.

Em que pese a gravidez precoce variar conforme os países e as regiões, há um consenso na literatura sobre a temática de que a falta de informação sobre a saúde; os direitos sexuais e reprodutivos; escolaridade e renda baixas são fatores que contribuem para o agravamento desse cenário. Os direitos sexuais estão relacionados a viver a sexualidade com respeito pelo próprio corpo e do (a) parceiro (a); de escolher o parceiro sem medo, culpa ou falsas crenças; de escolhas sobre querer ou não ter relações sexuais com fins reprodutivos; de expressar livremente a orientação sexual e a sexualidade; ter acesso à educação sexual e reprodutiva qualificada (BRASIL, 2010 a).

A abordagem sobre a gestação precoce implica na discussão sobre saúde sexual e reprodutiva. No âmbito internacional, as conferências das Nações Unidas, as quais o Brasil é signatário, asseguram a importância dos direitos reprodutivos das mulheres e meninas e destacam como esses são fundamentais para os direitos humanos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)² apontam como um dos objetivos: “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (Objetivo 5). Para que esse objetivo seja alcançado foram traçados 9 metas que, dentre outras questões, abordam a necessidade de acabar com todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres e meninas; realizar reformas para garantir às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos; assegurar o

²Em 2015 lideranças mundiais reuniram-se na Organização das Nações Unidas (ONU) para traçar um plano de ação com o objetivo de “erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade” que ficou conhecido como a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, foram estabelecidos 167 metas e 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos; adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis, etc.

Na esfera nacional foi instituída, por meio da Lei 13.798/2019, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência com o objetivo de difundir informações que possam contribuir para a redução da gravidez entre as adolescentes.

Refletir sobre a gravidez precoce no Brasil traz à tona muitas análises e discussões devido à abrangência da temática. Nesse sentido, este texto tem como objetivo contribuir para o debate acerca do fenômeno da gravidez na adolescência no Brasil e no estado do Espírito Santo, sem pretensão de esgotá-lo. Cabe salientar que buscamos trazer apontamentos de temas correlatos ao fenômeno estudado, como a violência sexual e o casamento precoce. Tendo em vista a amplitude dessas questões, não pretendemos fornecer, neste texto, análises aprofundadas, mas somente considerações que podem ser melhor investigadas em estudos posteriores.

Para a elaboração dos dados referentes ao perfil sociodemográfico das (os) adolescentes do estado do Espírito Santo (ES) foram utilizados os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD-Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

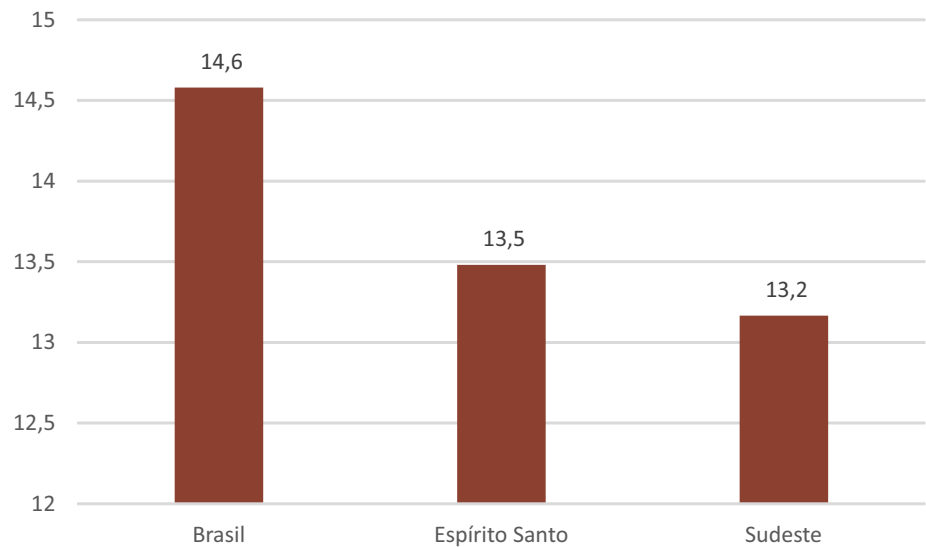
A maior parte da análise produzida neste estudo é baseada nos dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) desenvolvido pela DATASUS/Ministério da Saúde. O SINASC tem como objetivo realizar o cadastramento das Declarações de Nascidos Vivos (NV) a fim de subsidiar o conhecimento da situação de saúde em relação aos nascimentos ocorridos no país.

Os dados sobre notificações de estupro, que serão mencionados na seção 03, foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN) e elaborados pelo Observatório da Criança e do Adolescente, criado pela Fundação Abrinq³. O SINAN foi estabelecido pelo Ministério da Saúde em 2006 e busca apreender dados de violência interpessoal/autoprovocada nos serviços de saúde no Brasil.

De acordo com estimativas da PNAD-C no ano de 2019 as (os) adolescentes somavam cerca de 14,6% (30.545.451) da população nacional, 13,2% (11.632.433) do segmento populacional da Região Sudeste e 13,5% (541.266) da composição populacional do ES (Gráfico 01). Do total estimado de 541.266 adolescentes residentes no estado do ES no ano de 2019, 48,9% (264.846) estavam na faixa etária de 10 a 14 anos e 51,1% (276.420) na faixa etária de 15 a 19 anos (Gráfico 02). No que se refere ao sexo cerca de 50,4% (268.619) eram do sexo feminino e 49,6% (272.647) do sexo masculino.

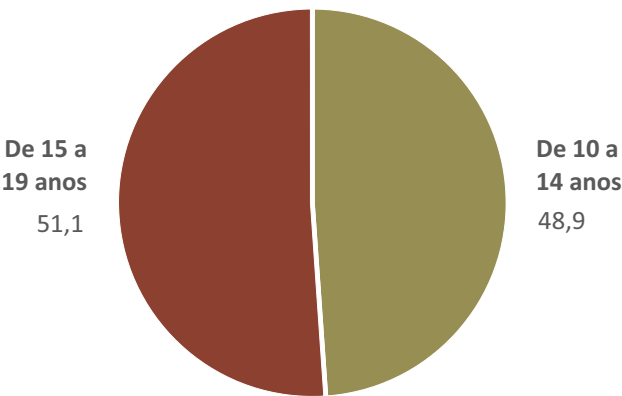
³ A Fundação Abrinq é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.

Gráfico 01 – Percentual de adolescentes (10 a 19 anos), Brasil, Sudeste e ES, 2019 (%)



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua)
Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Sociais (CES)

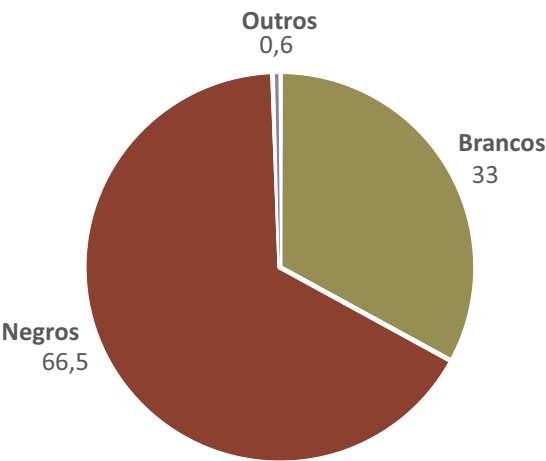
Gráfico 02 – Percentual de adolescentes (10 a 19 anos), por faixa etária, ES, 2019 (%)



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua)
Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Estima-se que no ano de 2019, 33% (178.541) da população adolescente do ES identificava-se como branca e 66,5% (359.742) como negra, como ilustra a Figura 3. Considera-se população negra a soma de pardos e pretos.

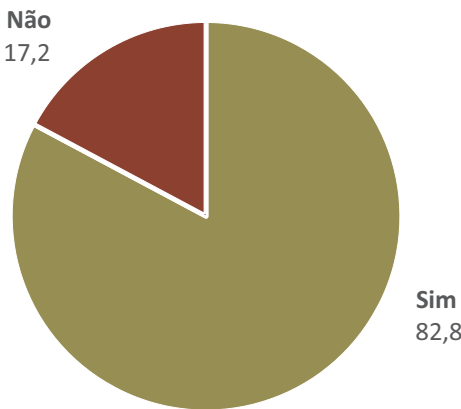
Gráfico 03 – Adolescentes (10 a 19 anos), por raça/cor, Espírito Santo, 2019 (%)



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua)
Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Sociais (CES)

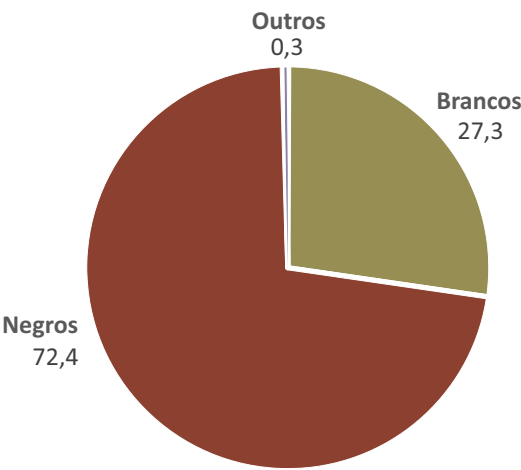
No que concerne à frequência escolar, as estimativas da PNAD-C indicaram que 17,2% dos adolescentes do ES, no ano de 2019, não frequentavam a escola (Gráfico 04). Esse percentual representa um total de 92.948 adolescentes, ou seja, um número elevado e preocupante. Dentre esse segmento populacional que não frequentavam a escola no ano de 2019 a maioria eram negros (72,4%), de acordo com o Gráfico 05.

Gráfico 04 – Frequência escolar, adolescentes (10 a 19 anos), ES, 2019 (%)



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua)
Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Gráfico 05 – Adolescentes (10 a 19 anos) que não frequentam a escola, por raça/cor, ES, 2019 (%)



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua)
Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Foto: Pixabay.com



A partir da segunda metade da década de 1960 o Brasil vivenciou significativas transformações, apresentando redução da fecundidade. Entre os anos 1980 e 2010 a taxa de fecundidade total (TFT)⁴ diminuiu de maneira relevante. Em 1980 a TFT foi de 4,7 filhos por mulher, em 1990 caiu para 2,9 filhos por mulher e no início do século XXI a taxa de fecundidade estava muito próxima ao nível de reposição da população. Até os anos 2000 a transição na fecundidade no Brasil foi marcada pelo rejuvenescimento e não pela postergação do nascimento do primeiro filho e aumento de intervalos entre o nascimento dos filhos, como aconteceu na maioria dos países desenvolvidos.

Esse fenômeno de rejuvenescimento da fecundidade, a partir dos anos 1980, indo na contramão da diminuição da fecundidade nas mulheres em outras faixas etárias é expressiva no Brasil quando comparada com outras regiões do mundo, o que justifica estudos e pesquisas para melhor compreensão das altas taxas de fecundidade entre as adolescentes, como sinaliza Martins e Verona (2019). A partir dos anos 2000 ocorre um declínio na fecundidade nas adolescentes de 15 a 19 anos, mas a fecundidade ainda é alta em relação aos países em desenvolvimento (CAVENAGHI, ALVES, 2014).

⁴Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado (DATASUS).

A abordagem e compreensão do fenômeno da gravidez precoce tem sido tratada na literatura a partir de duas principais vertentes: enquanto um problema social e de saúde pública e como uma experiência desejada pelas adolescentes em decorrência do contexto sócio-cultural ao qual elas se inserem.

2.1 - Adolescência e Sexualidade: alguns apontamentos

A sexualidade e a reprodução são dimensões primordiais da saúde que se relacionam com a qualidade de vida, logo, com o bem-estar físico, psicológico e social. É fundamental que a sexualidade seja entendida como construção social e enquanto uma dimensão que tem um papel crucial no processo de socialização das meninas e dos meninos adolescentes. O início da vida sexual é visto como um rito de passagem que transita entre a infância, a adolescência e a juventude, como elucida Castro e Abramovay (2004). Ademais, o começo da vida sexual e afetiva está entrelaçado com os papéis de gênero socialmente determinados e construídos.

A sexualidade perpassa por vários sentidos identitários, tais como o que é considerado socialmente como sendo o feminino e o masculino. Espera-se, por exemplo, que os meninos iniciem as atividades sexuais cada vez mais cedo, visto que a sexualidade e a virilidade estão imbricadas. Já em relação às meninas, há uma valorização da iniciação sexual tardia. Em termos gerais, os padrões e as expectativas sexuais são diferentes para ambos. As questões de gênero são, portanto, fortes determinantes para a gravidez precoce, como pontua Moraes-Partelli, Coelho e Freitas (2021, p. 03):

[...] as meninas não são reconhecidas como pessoas sexuadas em nossa sociedade patriarcal, o que inibe a adolescente de dizer “não” ao sexo indesejado, negociar a prática da relação íntima segura e ter acesso aos métodos anticoncepcionais e preservativos. Além disso, o impacto da gravidez na adolescência também não é equânime para meninos e meninas, pois as meninas se afastam da escola para cuidar dos filhos e, normalmente, são abandonadas por seus parceiros.

As transformações no âmbito da sexualidade ou mesmo de uma “liberdade sexual” ocorrido nas últimas décadas não vieram acompanhadas, necessariamente, da discussão acerca do corpo e dos papéis sexuais e de gênero. De modo que, “[...] por trás de uma aparente liberalidade ou indiferença, encontra-se, muitas vezes, uma moralidade rígida e punitiva, quando os valores familiares são transgredidos” (DIAS; TEIXEIRA, 2010, p. 126).

Ter conhecimento e acesso a algum método contraceptivo é fundamental para reduzir o número de gestações precoces, todavia não é suficiente já que utilizá-los implica em assumir e expressar a sexualidade, o que pode não ser tão simples para os adolescentes e, principalmente, para as meninas (DIAS; TEIXEIRA, 2010).

O sexo seguro não se restringe ao uso de insumos/dispositivos técnicos de

prevenção (métodos contraceptivos, como preservativo e contracepção de emergência), mas demanda desenvolvimento de habilidades relacionais e afetivas no processo de construção da autonomia juvenil, dimensões fundamentais que permitem ao jovem reconhecer e articular desejos e limites sexuais e a aprender a se antecipar e se preparar para os atos sexuais (CABRAL; BRANDÃO, 2020, p. 02).

A maneira como os adolescentes expressam e vivenciam a sexualidade vincula-se ao contexto social ao qual eles estão inseridos. No geral, o início da vida sexual caracteriza-se por uma série de dúvidas, inseguranças, medos e desconhecimentos sobre a questão. Esse contexto contribui para o aumento da vulnerabilidade e, consequentemente, problemas no que diz respeito ao aspecto da sexualidade, principalmente, se fizerem parte de um cenário onde não possuem explicações suficientes acerca da temática.

Uma questão que não pode ser ignorada no debate sobre as gestações precoces é o papel dos meninos adolescentes que se tornam pais. Sabe-se que, devido a uma construção histórica pautada na desigualdade de gênero, historicamente as funções vinculadas aos cuidados foram designadas às mulheres, desse modo os homens tendem a não participarem de forma ativa dos cuidados com os filhos ou mesmo de dimensões que envolvam todo o processo da paternidade.

Cabral e Brandão (2020) salienta que existe um “muro do silêncio” no que se refere à paternidade na adolescência. Esse silenciamento, para o autor, ocorre devido aos seguintes fatores: em nossa cultura o filho é visto como sendo de responsabilidade somente da mãe; o homem jovem/adolescente é visto, sob um estereótipo machista, como o promíscuo, inconsequente, impulsivo; o jovem pai é percebido como ausente e irresponsável; o pai adolescente é reconhecido mais no papel de filho do que de pai.

Nesse sentido, a inserção dos adolescentes homens nas abordagens que visam diminuir as gravidezes precoces é um obstáculo, pois nota-se uma invisibilidade dos meninos pais quando se fala sobre o evento da gravidez, fato que reforça a atribuição de responsabilidade pela gravidez somente para as meninas. Incluir os meninos no debate sobre a prevenção da gravidez, de forma séria e comprometida, implica em reflexões sobre masculinidades, desigualdade de gênero, virilidade, etc. O desafio é que eles se sintam responsáveis pela gravidez (CABRAL; BRANDÃO, 2020).

Compreender as construções sociais que envolvem a esfera da reprodução nos adolescentes é importante, mas também é fundamental fazer um exercício, profissionais da Saúde, de Educação e mesmo entre pesquisadores, sobre o lugar ou o “não lugar” que damos a eles na gravidez durante a adolescência. Em geral, a gravidez na adolescência se confunde na literatura e nas ações sociais com a maternidade na adolescência, ou seja, muito se fala sobre a gravidez, mas, na verdade, fala-se mesmo sobre a adolescente grávida (BRASIL, 2017, p. 173).

2.2 - Gravidez na adolescência enquanto um problema de saúde pública

No Brasil, até meados do século XX, a gravidez na adolescência não era considerada um problema social e de saúde pública, não sendo, portanto, uma questão de interesse para os pesquisadores. A partir desse período observam-se estudos sobre o fenômeno com abordagens de áreas diversas, tais como a saúde, psicologia, sociologia, demografia, dentre outras.

Diversas pesquisas demonstraram que a gestação na adolescência é considerada um evento de risco biológico tanto para as mães quanto para os bebês recém-nascidos. Isso porque as mães adolescentes tendem a ter mais complicações de saúde durante a gestação em relação às mães adultas, tais como: anemia; tentativas de abortamento; desnutrição; (pré) eclampsia; hipertensão; depressão pós-parto; sobrepeso (MICHELAZZO et al., 2004; SANTOS et al., 2014).

Os riscos são ainda maiores em relação às meninas de 10 a 14 anos devido a imaturidade física e biológica das mesmas. Os bebês nascidos de mães adolescentes têm mais propensão a baixo peso ao nascer e serem prematuros quando comparados com as mães adultas. Além disso, tem-se um número elevado de adolescentes que morrem em decorrência de complicações oriundas da gestação e do parto (UNFPA, 2013).

O documento realizado pela Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI, 2014) ao analisar os dados referentes às gravidezes dos nascidos vivos de mães adolescentes, no ano de 2011, constatou que cerca de 20% da mortalidade infantil foram de bebês oriundos de gestação precoce. Além disso, o documento pontuou que o baixo peso entre os recém-nascidos foi cerca de duas vezes maior entre bebês de mães adolescentes. E que a mortalidade neonatal foi cerca de três vezes maior entre os bebês de mães adolescentes quando comparados com os filhos das mães adultas, no ano de 2011.

Tradicionalmente, os resultados das pesquisas acerca da temática em questão indicam que as meninas menos escolarizadas possuem mais chances de serem mães precocemente (NOVELLINO, 2011; LOSS; SAPIRI, 2005). Assim, a gestação precoce contribui de forma significativa para a evasão escolar das meninas grávidas, especialmente, mas também dos meninos que viram pais. Entretanto, outros estudos têm revelado que a evasão escolar é um fenômeno que precede a gestação precoce, ou seja, há uma tendência de meninas que já estavam fora da escola engravidarem. O abandono escolar advém da maternidade precoce ou mesmo da precária situação socioeconômica vivida pelas adolescentes, anterior a gravidez (SABROZA, et al., 2004).

Segundo a ONU (2018) a cada ano a mais de estudo o risco de engravidar no pe-

ríodo da adolescência diminui cerca de 5 a 10%. O maior acesso à educação escolar pode contribuir para o conhecimento referente ao controle reprodutivo, métodos contraceptivos, educação sexual, empoderamento e autonomia sobre o corpo e a própria sexualidade. A escola é um lócus privilegiado quanto a difusão de conhecimentos que proporcionam a redução da incidência de gravidezes precoces.

O estudo realizado por Martins e Verona (2019) buscou identificar se houve correlação entre a diminuição na taxa de fecundidade entre as adolescentes e o aumento da cobertura escolar, considerando as variáveis demográficas e socioeconômicas dos Censos Demográficos dos anos de 1990, 2000 e 2010. Os resultados evidenciaram que a cada Censo as adolescentes com menos anos de escolaridade apresentaram maiores chances de engravidar em comparação com as meninas com pelo menos 9 anos de escolaridade. Nas palavras das autoras:

Os resultados deste estudo contribuíram para o entendimento da relação entre fecundidade na adolescência e escolaridade em um contexto de declínio da fecundidade adolescente no Brasil, ao mesmo tempo em que se observou aumento da cobertura escolar. Os principais achados mostram que adolescentes de grupos de baixa e intermediária escolaridade tiveram suas chances de ser mãe aumentadas ao longo do tempo, em relação ao grupo com maior escolaridade, confirmando uma trajetória de aumento dos diferenciais da fecundidade adolescente segundo escolaridade no país (VIEGAS; VERONA, 2019, p. 68).

É possível identificar ainda que existe um recorte racial, uma vez que há mais casos de gravidezes entre as meninas negras, pobres e com menor escolaridade (INDICA, 2017). Além dos impactos negativos mencionados, ressalta-se que a gravidez precoce traz prejuízos econômicos e para o desenvolvimento de um país. O Fundo da População das Nações Unidas em parceria com a ITAIPU Binacional evidenciou que a cada US\$1 investido em planejamento familiar, poupa-se US\$ 1,47 em assistência médica. Este mesmo investimento feito na população adolescente poupa-se US\$ 98,2 até o fim da vida reprodutiva. Considerando o ano de 2015, para cada R\$ 1 real investido na saúde sexual e reprodutiva das adolescentes estima-se um retorno de R\$ 365. Ainda nesse viés, o relatório do Banco Mundial apontou que o Brasil poderia aumentar sua produtividade anual, caso um número significativo de meninas engravidasse depois dos 20 anos de idade.

2.3 - Dimensões sócio-culturais vinculadas ao desejo de ser mãe

É inegável que do ponto de vista social e da saúde pública a gravidez precoce tem impactos negativos para a saúde da mãe, do bebê e para o desenvolvimento social de um país, conforme já sinalizado na subseção anterior. Entretanto, pesquisas revelam que o fenômeno pode ser considerado um evento positivo na vida de muitas meninas e também de meninos.

É comumente difundida a ideia de que a gravidez entre adolescentes é algo que não foi planejado, indesejado e fruto de acidente. No entanto, o desejo de ser mãe ou mesmo pai, fato que implica no planejamento da gravidez é uma realidade na vida de muitas meninas e, mesmo que em menor proporção, também de meninos, que não pode ser negligenciada.

A adolescência é um momento da vida socialmente desvalorizado. Em contrapartida, a gravidez é um fenômeno socialmente estimado. Sendo assim, estudos sinalizaram que a gravidez pode significar um status social, principalmente para as meninas, que desejam a maternidade como projeto de vida e como forma de reconhecimento social, de modo que “[...] a gestação na adolescência se apresenta como um projeto viável e valorizado, em um contexto onde não existem muitas alternativas possíveis de implementação de outros projetos de vida” (DIAS; TEIXEIRA, 2010, p. 127).

O estudo realizado por Reis e Oliveira-Monteiro (2007) com adolescentes de 14 a 19 anos moradores da periferia de São Paulo identificou que a falta de oportunidades para estudar e trabalhar somados as carências emocionais seriam os principais motivos que levariam adolescentes a desejarem a maternidade. Além disso, os conflitos familiares, as brigas e os desentendimentos são elementos relatados pelos participantes da pesquisa que contribuíram para que eles tivessem vontade de constituir uma família. As opções escolhidas tanto por meninas quanto por meninos quando ambos foram indagados sobre os principais motivos que levariam a gravidez precoce foram: “falta de opções de vida”; “falta de oportunidade para estudar ou trabalhar” e o “desconhecimento sobre métodos anticoncepcionais.” Cabe destacar que essa última resposta foi uma opção mencionada por um número muito pequenos dos adolescentes. A respeito das conclusões desse estudo, os autores salientam que:

[...] entendemos que as dimensões psicológicas, sociológicas e ambientais que cercam o fenômeno da procriação de adolescentes, devem ser ressaltadas, especificamente nesses territórios de periferias sociais e investigação urbanas. Trata-se de um fenômeno de dimensão psicossocial, que se for encarado em âmbitos restritos de disciplinas segmentadas, perderá sua própria natureza (REIS; OLIVEIRA-MONTEIRO, 2007, p. 62).

Nesse mesmo viés, a pesquisa socioantropológico feita por Pantoja (2003), em Belém do Pará, identificou que a gestação proporcionou mudanças de status social entre as adolescentes grávidas e, além disso, a reafirmação de projetos de mobilidade social pelas meninas a partir da gravidez. Isso porque o evento da maternidade se constitui como estímulo para retomar os estudos, no caso das meninas fora da escola, ou para continuar estudando visando um futuro melhor para o bebê ou mesmo “ser alguém na vida.” O contexto investigado pela autora aponta que a gestação se apresenta como um tipo de “passaporte para entrada na vida adulta,” uma vez que o status da maternidade propicia que a adolescente seja reconhecida como adulta tanto pelos familiares e pela comunidade escolar.

O evento da gestação e maternidade pode ser almejado, principalmente, pelas adolescentes porque a identidade de mãe possibilita um reconhecimento por parte das pessoas que convive com elas, de modo a propiciar um sentido à vida das meninas. Em um cenário marcado pela falta de expectativas e projetos, a gravidez se apresenta como uma possibilidade de vislumbrar um futuro que faça sentido. De acordo com Dias e Teixeira (2010, p. 129) a gravidez para a mãe adolescente é uma forma de “[...] reconhecer a si mesma, de marcar seu próprio espaço na família e de ser reconhecida nos seus ambientes de convívio”.

Dessa maneira, ressalta-se que a análise da precocidade gestacional somente pela lógica da gravidez indesejada ou não-planejada oculta a complexidade do fenômeno e, conseqüentemente, contribui para “soluções” simplistas e não eficientes como forma de diminuir as incidências das gravidezes. Castro (et al., 2004, p. 134) indica que essa perspectiva ignora outros significados possíveis da gravidez na vida das meninas, tais como: “[...] idealizações sobre maternidade e relações entre sexos, a diversidade possível de subjetividades variadas, as buscas criativas de comunicação e socialização com e entre corpos”. As autoras argumentam que a não intencionalidade da gravidez é uma situação que ocorre tanto entre adolescentes quanto entre mulheres adultas, contudo a ênfase geralmente é dada ao primeiro grupo.

Trazer essa perspectiva para o texto não significa ignorar os inúmeros problemas sociais decorrentes da temática em voga. O que se busca ao destacar o outro ponto de vista é “[...] o cuidado com análises funcionalistas, dicotomias e associações empobrecedoras da complexidade compreensiva sobre o tema e seus múltiplos significados, inclusive de poder, mesmo que, em muitos casos, ilusórios para as jovens” (CASTRO, et al., 2004, p. 135).

Não se trata aqui, de fazer a condenação ou o elogio da gravidez na adolescência. Trata-se, sim, de trazer à cena uma realidade que, sem negligenciar os perfis epidemiológicos, nos remetem a histórias: trajetórias que contêm sonhos, esperanças, dores, decepções e que permitem às meninas se apropriar das adversidades, para transformar – mesmo que ilusoriamente – o seu cotidiano em algo que valha a pena ser vivido. Ser mãe para estas meninas, talvez seja uma das poucas formas que lhes restam, no sentido de se colocarem no mundo como sujeitos sociais (ABRAVOMAY; CASTRO, 2004, p. 135).

Em uma conjuntura onde a maternidade é desejada pelas meninas, vale algumas reflexões sobre a autonomia e escolha consciente dessa decisão. Será que diante de uma realidade com poucas possibilidades de projetos de vida, seja para o momento presente ou para o futuro, pode-se falar, realmente, de uma escolha válida? Esse contexto evidencia a importância e necessidade de políticas públicas que possibilitem aos adolescentes construir projetos de futuro que contemplem dimensões ligadas às realizações diversas, de modo que a gravidez não seja a única alternativa de futuro vislumbrada por esse segmento populacional.



Foto: Pixabay.com

As uniões ou casamentos em idade precoce são indicadores que devem ser considerados nas discussões sobre saúde sexual e direitos reprodutivos das adolescentes. A ONU utiliza o termo “casamento infantil, prematuro e forçado” para referir-se a essas uniões como forçadas enquanto forma estratégica de destacar as desigualdades estruturais que sujeitam as meninas a essa situação, numa conjuntura onde não há escolha⁵.

Estudos evidenciam que casamentos ou uniões precoces são prejudiciais para a trajetória de vida das meninas, posto que se configuram como impedimento no que diz respeito aos aspectos educacionais, profissionais e subjetivos como um todo. Em geral os casos de casamento e uniões precoces recai sobre as meninas e não sobre os meninos. E essas uniões tendem a acontecer com homens bem mais velhos.

O estudo realizado pela UNICEF⁶ ressaltou que, devido aos efeitos da pandemia

⁵Disponível em: <https://gtagenda2030.org.br/2020/03/16/casamento-infantil-peso-sobre-o-futuro-de-meninas-e-mulheres/>. Acesso em: set. 2021.

⁶Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/10-milhoes-de-meninas-a-mais-em-risco-de-casamento-infantil-devido-a-covid-19>. Acesso em: set. 2021.

ocasionada pela propagação do COVID-19, cerca de 10 milhões de casamentos infantis podem ocorrer a mais até o final desta década. O fechamento de escolas, crise econômica, morte dos pais e gravidez são aspectos que contribuíram para a maior vulnerabilidade das meninas em relação ao casamento precoce. O Brasil está na 4ª posição no ranking internacional relacionado ao casamento e união de meninas menores de 18 anos e está entre os cinco países da América e do Caribe com maior ocorrência de casos (PLAN INTERNACIONAL BRASIL, 2019).

A pesquisa feita pela Plan Internacional Brasil denominada “Tirando o véu: estudo sobre casamento infantil no Brasil” traz contribuições pertinentes sobre o cenário do fenômeno no Brasil. Não obstante a alta ocorrência em âmbito nacional, o casamento precoce é uma realidade socialmente invisível. Dessa maneira, não é visto como um problema social capaz de mobilizar os órgãos públicos de modo a constituir pauta das políticas públicas. As principais motivações para o casamento precoce identificadas pelo estudo mencionado, em ordem de predominância, foram: gravidez não planejada; amor e desejo de constituir família; vivência da sexualidade (perda da virgindade); necessidade de saída de lares conflituosos; desejo pela maternidade; proteção contra violência e sanção da comunidade (julgamento moral). Nessa lógica, “[...] o poder de concessão e decisão frente ao casamento deve ser relativizado, pois muitas vezes o matrimônio é pautado primariamente pelas necessidades e/ou pela falta de oportunidades do que pelo desejo de uma união” (PLAN INTERNACIONAL BRASIL, 2019, p. 9).

As consequências do casamento precoce para as meninas, revelada na pesquisa supracitada, por ordem de dominância, são: aumento do serviço doméstico; cuidado parental exercido predominantemente por elas; falta de profissionalização; exclusão do mercado de trabalho; atraso e/ou abandono escolar; restrição da mobilidade e da liberdade.

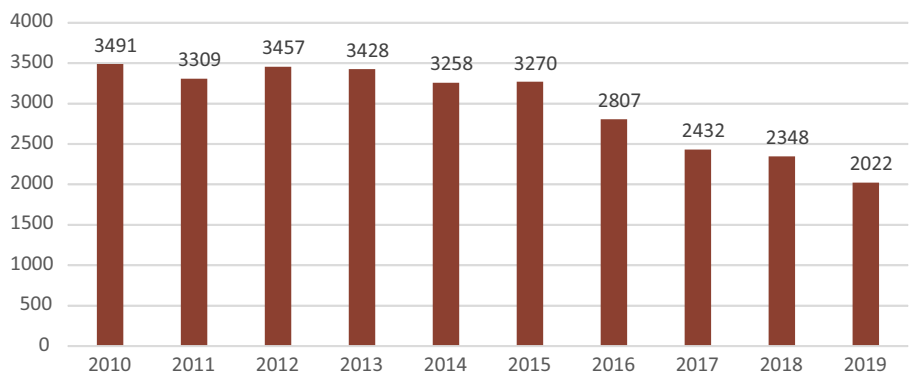
A gravidez e o casamento precoce são amplos e multicausais, logo, não há como afirmar com exatidão que ambos estão relacionados de forma direta, porque engendram configurações específicas. Todavia, não se pode negligenciar que um dos motivos do casamento precoce decorre da gravidez. E que, por outro lado, as formações familiares precoces também contribuem para as gestações na fase da adolescência.

Em consonância com o que foi discutido na subseção 2.3 deste texto, as investigações sobre casamento precoces devem considerar o contexto cultural ao qual se insere as meninas e os meninos adolescentes. O estado do Espírito Santo apresenta uma diversidade étnico-cultural, constituindo-se de povos pomeranos, indígenas, comunidades quilombolas, dentre outros. Para uma análise mais apurada e cautelosa sobre o casamento precoce no estado do ES é imprescindível, portanto, atentar-se para esse contexto cultural.

O gráfico 06 ilustra o número de casamentos de crianças e de adolescentes do se-

xo feminino no Espírito Santo no período de 2010 a 2019. Em linhas gerais, há que se destacar que os dados informados nessas tabelas devem ser analisados com atenção, pois é preciso considerar que há um número expressivo de subnotificações do fenômeno, de tal modo que os números certamente são mais elevados do que os registrados. No ano de 2019 foram registrados um total de 2.022 casamentos de crianças e adolescentes de até 18 anos no ES.

Gráfico 06 – Número de casamentos de crianças e adolescentes* do sexo feminino, Espírito Santo, 2010-2019



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Estatísticas do Registro Civil.
Elaboração: Observatório da Criança e do Adolescente- Fundação Abrinq

*Meninas com até 18 anos de idade.



Foto: Pixabay.com

Uma análise qualificada sobre a gestação precoce perpassa por considerar as particularidades das faixas etárias correspondentes ao período da adolescência. O segmento populacional de 10 a 14 anos requer uma abordagem diferenciada em relação às gravidezes de meninas de 15 a 19 anos, visto que as gestações naquela faixa etária são consideradas, de acordo com a legislação, consequências de casos de violência sexual⁷. Além disso, as complicações físicas e emocionais para as meninas grávidas de 10 a 14 anos são ainda maiores em relação as meninas gestantes de 15 a 19 anos.

O Supremo Tribunal Federal⁸ determinou, no Brasil, que o abuso sexual de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade constitui estupro presumido. Desse modo, a súmula 593 do STF/2017 preconizou que as relações sexuais ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos são consideradas crime sexual contra vulnerá-

⁷De acordo com a OMS a violência sexual é definida como “todo ato sexual, tentativa de consumir um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas; ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção de outra pessoa, independente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho”. A violência sexual abrangem, portanto, o estupro e abuso sexual.

⁸Em acordo com o que determina o Código Penal Brasileiro (Lei Decreto 2848, artigo 217-A).

vel, independente da comprovação de discernimento ou não para o consentimento da vítima.

Em que pese a maior incidência de complicações em função da gestação precoce em meninas na faixa etária de 10 a 14 anos, nota-se que as políticas de enfrentamento do fenômeno se direcionam, predominantemente, para as meninas de 15 a 19 anos. Nesse sentido, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escola (PeNSE, 2021) identificou que em relação as orientações sobre prevenção de gravidez, HIV/AIDS e outras Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) os adolescentes na faixa etária de 13 a 15 anos (72,6%) receberam menos informações em comparação aos adolescentes de 16 a 17 anos (80,8%).

Embora a iniciação sexual tenha maior prevalência entre os adolescentes com mais idade, os resultados indicaram que parcela significativa dos adolescentes iniciou a vida sexual com 13 anos ou menos. Com efeito, um menor acesso às orientações relativas à saúde sexual e reprodutiva entre os mais jovens parece não convergir com a realidade observada (PeNSE, 2021, p. 88).

Essa perspectiva alinha-se com a vigência de uma cultura conservadora e moralista que menospreza a relação sexual nos primeiros anos da adolescência. Na contramão desse viés, a pesquisa supracitada apontou que a média de idade da primeira relação sexual tem sido de 13,4 anos para os meninos e de 14,2 anos para as meninas. E, ainda, que 35,4% dos escolares de 13 a 17 anos já tiveram relação sexual. Dentre os adolescentes que mencionaram já terem tido relação sexual, cerca de 36,6% relataram ter tido a primeira experiência sexual com 13 anos de idade.

Os resultados da PeNSE sinalizaram ainda que cerca de 14,6% dos escolares de 13 a 17 anos alguma vez na vida foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo contra a sua vontade. As meninas foram as que mais indicaram ter sofrido esses tipos de violência (20,1%), um percentual que representa o dobro do valor observado para os meninos (9%). O estudo demonstrou que 6,3% dos escolares foram forçados a terem relações sexuais não consentidas. Entre as meninas esse percentual foi de 8,8% enquanto entre os meninos esse percentual foi de 3,7%.

É inegável as implicações negativas da violência sexual na vida das meninas e meninos que sofrem este tipo de violação que afetam o campo psicológico, físico, econômico. O estupro, por exemplo, além de poder gerar uma gravidez precoce é suscetível da vítima contrair uma ISTs. No âmbito psicológico, o estupro pode causar diversos transtornos, como [...] “depressão, fobias, ansiedade, uso de drogas ilícitas, tentativas de suicídio e síndrome de estresse pós-traumático” (Faúndes apud CERQUEIRA, 2014, p. 4).

Cerqueira e Coelho (2004) evidenciaram que, no ano de 2011, dentre as notificações relacionadas ao estupro cerca de 70% vitimizaram crianças e adolescentes. No que tange as consequências sofridas pelas vítimas de estupro destacam-se estresse pós-traumático (23,3%); transtorno de comportamento (11,4%) e gravidez (7,1%). O estudo salientou ainda que o percentual de vítimas que ficaram grávidas em decorrência do estupro cresce para 15% quando considera-se somente os casos em que houve penetração vaginal e a faixa etária de 14 e 17 anos. Não obstante a importância do assunto, poucos estudos quantitativos sobre a temática foram realizados no Brasil, provavelmente por causa da dificuldade de aquisição de dados e informações fidedignas sobre o fenômeno (CERQUEIRA; COELHO, 2014).

O relatório da ONU destaca que a América Latina é a segunda região do mundo com maior incidência de maternidade infantil, ficando a África em primeiro lugar de casos. O Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher realizou, em 2016, a campanha internacional: Gravidez Infantil Forçada é Tortura⁹. A campanha denuncia a impunidade da violência sexual contra as meninas e defende a gravidez forçada entre menores de 14 anos como tortura. A campanha indicou que no momento em que a menina se torna mãe ocorre três principais tipos de violações: a primeira relacionada a relação sexual indesejada; as outras dizem respeito a obrigar a menina a ter uma gravidez indesejada e forçar a crianças a ser mãe.

Nessa linha, a pesquisa realizada pela Rede Feminista de Saúde, que mapeou o perfil das meninas mães menores de 14 anos entre 2010 e 2019, apontou que em média uma criança é mãe a cada 20 minutos no Brasil. As pesquisadoras chamam atenção que os dados não se tratam meramente de casos de gravidez precoce, mas de estupro de vulnerável, como já mencionado nesta seção. Os resultados da investigação identificaram ainda que a mortalidade materna afeta mais as mães menores de 14 anos em comparação com as mães nas outras faixas etárias e que cerca de 344 meninas por ano, em média, tiveram um bebê natimorto (3.448 em dez anos), que representa uma taxa de 13,64 natimortos por mil nascidos vivos. Esse número é mais elevado que a taxa geral de óbitos fetais para todas as faixas etárias no Brasil, que foi de 10,72.

A pesquisa “Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil”, feita pela UNICEF em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que no ano de 2020 o ES registrou, em média, três estupros de crianças e adolescentes por dia. O estudo demonstrou que na maioria dos estados brasileiros os números de registros desses crimes atenuaram, entretanto no ES os números cresceram (UNICEF, 2021).

Os casos de gravidezes de meninas menores de 14 anos são presumíveis de

⁹Disponível em: <https://catarinass.info/gravidez-infantil-forcada-e-tortura/>. Acesso em: out. 2021.

aborto¹⁰ conforme assegura o Sistema Único de Saúde (SUS), por envolver violência e ser gravidez de risco (já que o corpo das meninas nessa faixa etária não está totalmente desenvolvido). No entanto, o que se observa é uma dificuldade no acesso e na garantia do direito a interrupção da gestação¹¹.

As gravidezes de crianças não deixam de ser um tema complexo, controverso e de difícil caracterização devido a subnotificação do fenômeno. De um lado, a legislação preconiza que as relações sexuais com menores de 14 anos constituem-se como crime sexual contra vulnerável independente do consentimento ou não. Por outro lado, quando se trata de relações com parceiros íntimos outros aspectos deveriam ser considerados além do consentimento, para uma análise mais fidedigna e cuidadosa, tais como: início da atividade sexual e idade do possível autor da violação. Nesse sentido, faz-se necessário qualificar as informações disponibilizadas no SINASC, com um melhor preenchimento das variáveis relativas à mãe, gestação e idade do pai. Ademais, torna-se fundamental qualificar informações a respeito de “local de ocorrência” e “violência de repetição” no SINAN, tendo em vista o elevado número de Ignorado (SOUTO, et al., 2017).

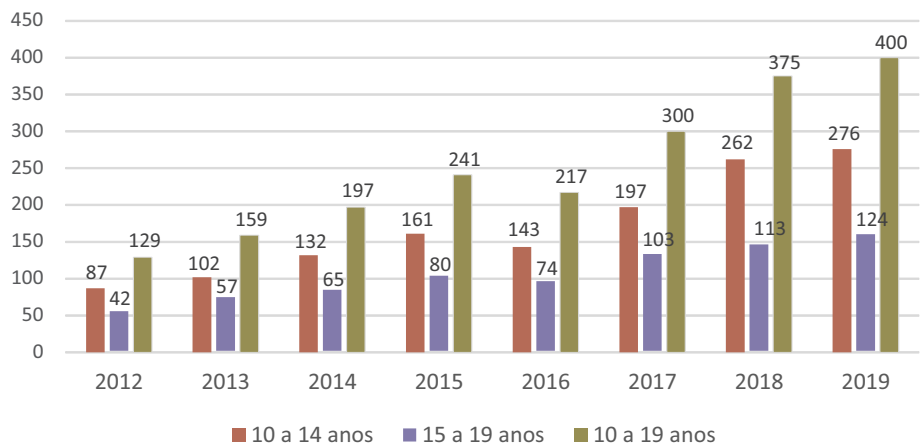
A luz de tais considerações, salienta-se que os casos de estupros e de violência sexual sofridos pelas crianças e adolescentes, em sua maioria meninas, são bem maiores do que os registrados pelo SINAN. A subnotificação dessas violências, infelizmente, é uma realidade no país. A insuficiência de informações oficiais se apresenta como uma barreira para a real dimensão do fenômeno de violências sofridas pelo segmento populacional mencionado, fato que limita a elaboração de políticas públicas eficientes.

O gráfico 07 explicita que os casos de notificações de estupros de crianças de 10 a 14 anos, no ES, foram mais elevados em relação aos adolescentes da faixa etária de 15 a 19 anos durante o período de 2012 a 2019. No ano de 2019 identificou-se um registro de 276 casos de estupros de crianças de 10 a 14 anos e um total de 124 casos em relação aos adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos. Nota-se um aumento das notificações no período de 2012 a 2019 em todas as faixas etárias analisadas.

¹⁰Em caso de Anencefalia Fetal o aborto também é permitido pela legislação.

¹¹Vale ressaltar um caso que foi nacionalmente divulgado em agosto de 2020 de uma criança do estado do ES, abusada sexualmente dos 6 aos 9 anos, que ficou grávida em virtude do abuso sexual por um familiar. Em um cenário de protestos por parte de algumas entidades religiosas e resistência por parte de alguns profissionais da saúde, a menina teve que se deslocar para outro estado para que o procedimento do aborto fosse realizado. Cf. <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2020/08/16/menina-que-engravidou-apos-ser-estuprada-deixa-o-es-para-interromper-gravidez-em-outro-estado.ghtml>. Acesso em set. 2021.

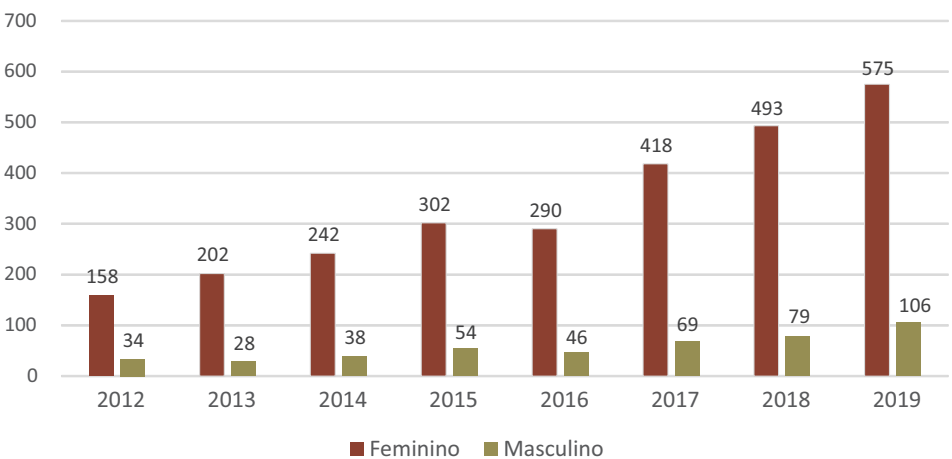
Gráfico 07 – Notificação de estupro contra crianças e adolescentes, por faixa etária, Espírito Santo, 2012-2019



Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
Elaboração: Observatório da Criança e do Adolescente- Fundação Abrinq

No que diz respeito às notificações de estupro contra menores de 19 anos de idade por sexo, observa-se que as meninas sofreram mais violações em relação aos meninos. Esses dados vão na direção do que já vem sendo identificado pela literatura sobre a temática que elucidam que as meninas são mais vulneráveis as situações de violências por causa da desigualdade de gênero e estrutura patriarcal que predomina na nossa sociedade. No ES, em 2019, estima-se um total de 575 registros de estupro contra as meninas e um total de 106 contra os meninos (Gráfico 08).

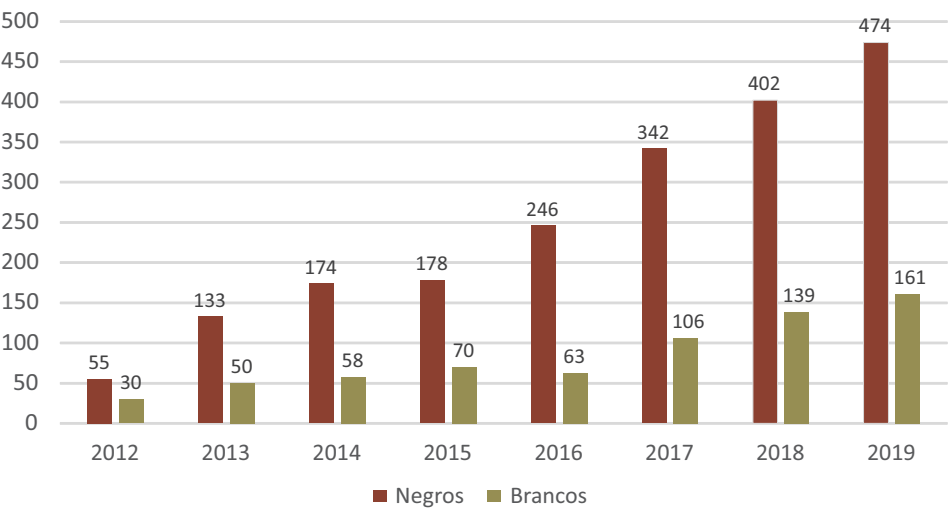
Gráfico 08 – Notificação de estupro contra menores de 19 anos de idade, por sexo, Espírito Santo, 2012-2019



Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
Elaboração: Observatório da Criança e do Adolescente- Fundação Abrinq

Quando se utiliza o recorte racial na análise dos dados de notificações de estupro contra menores de 19 anos de idade, ressalta-se um número maior de registros em relação as crianças e adolescentes negras quando comparados com as meninas e meninos brancos (Gráfico 09).

Gráfico 09 – Notificação de estupro contra menores de 19 anos de idade, por raça/cor, Espírito Santo, 2012-2019



Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
Elaboração: Observatório da Criança e do Adolescente- Fundação Abrinq

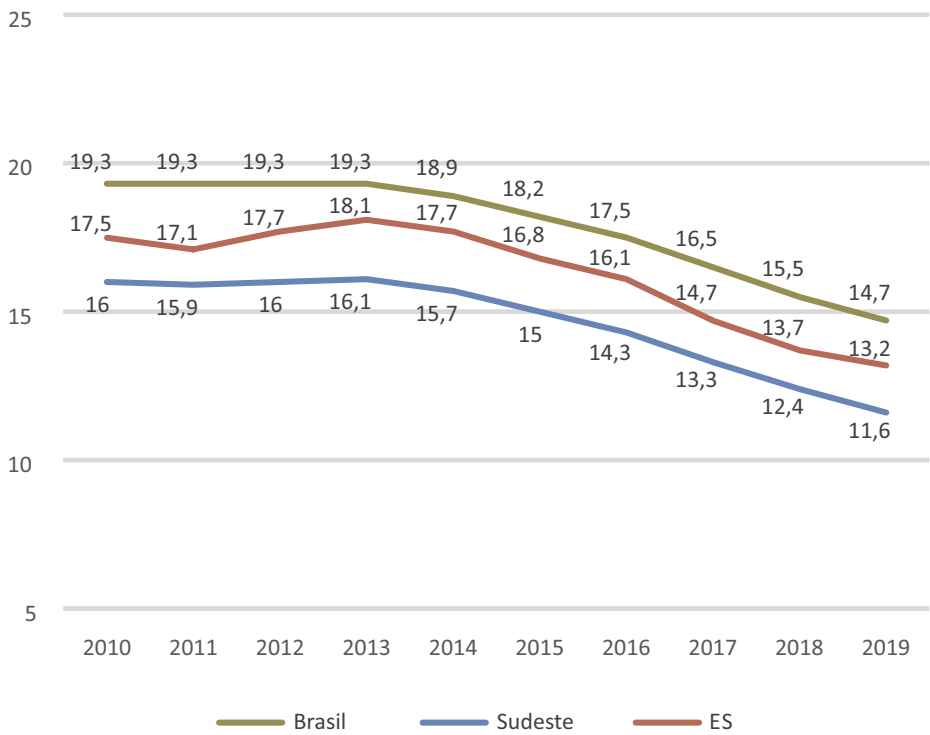


Foto: Pixabay.com

Em relação à proporção de bebês nascidos vivos¹² de mães adolescentes, no período de 2010-2019, observa-se que esse percentual apresentou tendência decrescente no Brasil, Sudeste e ES. No estado do ES, o percentual de nascidos vivos das mães na faixa etária de 10 a 19 passou de 17,5% em 2010 para 13,2% no ano de 2019. A proporção de nascidos vivos no estado em 2019 ficou 1.6 pp acima da região Sudeste e 1.5 pp abaixo do Brasil (Gráfico 10). Embora o número de gravidezes tenha diminuído o fenômeno precisa ser foco de atenção para as políticas públicas, já que prejudica as meninas exercerem seus direitos básicos.

¹²De acordo com a Organização da Saúde (OMS) o indicador nascido vivo diz respeito a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da separação, respira ou apresenta quaisquer outros sinais de vida, tais como batimento do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta.

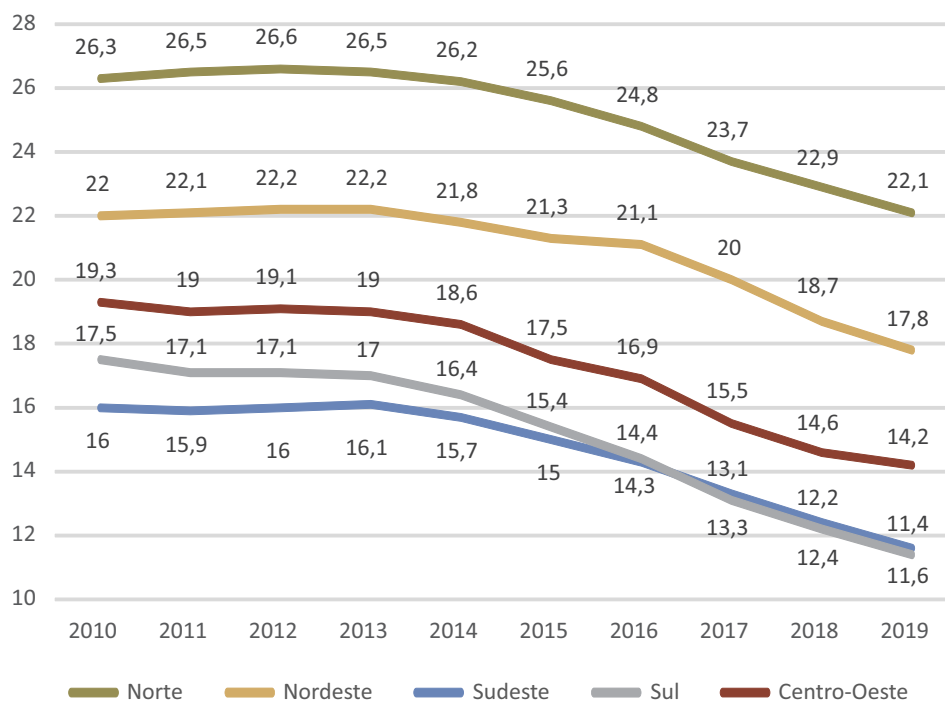
Gráfico 10 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Brasil, Sudeste e ES, 2010-2019 (%)



Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
Elaboração: Observatório da Criança e do Adolescente- Fundação Abrinq

O gráfico 11 explicita a desigualdade regional no Brasil no que se refere à gravidez precoce. Todas as regiões brasileiras apresentaram queda na proporção de nascidos vivos de mães adolescentes considerando o período de 2010- 2019. Apesar disso, os dados do gráfico mostram que as regiões Norte e Nordeste possuem um percentual significativamente elevado em comparação às demais regiões. No ano de 2019 os percentuais de nascidos vivos das regiões do Norte e Nordeste eram de 22,1% e 17,8%, enquanto nas regiões Sudeste e Sul foram de 11,6% e 11,4%, respectivamente. A proporção de nascidos vivos no Norte ficou 10.5 pp acima da região Sudeste em 2019.

Gráfico 11 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Regiões do Brasil, 2010-2019 (%)

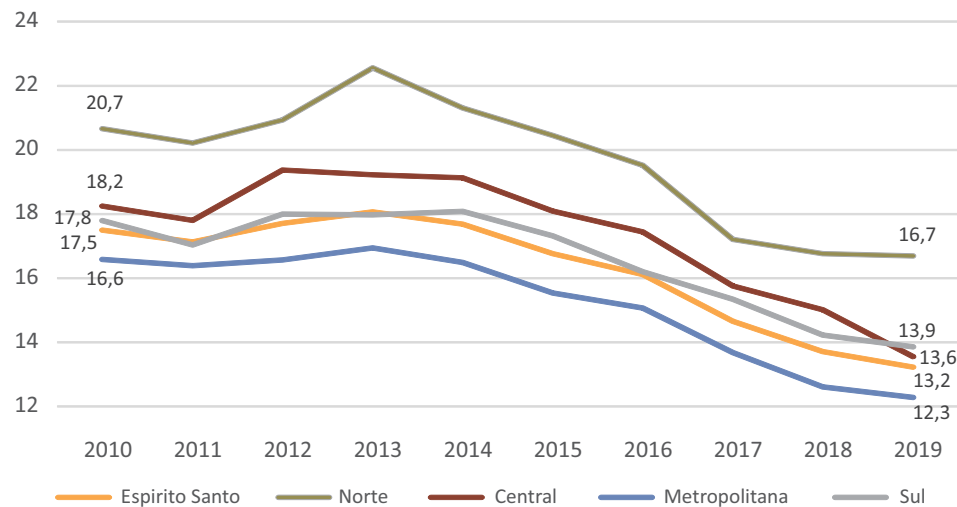


Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

No que diz respeito à proporção de nascidos vivos de mães adolescentes por regiões da saúde do ES¹³, destaca-se que a Região Norte apresentava, no período de 2010 a 2019, a proporção mais elevada. Sendo que no ano de 2019 o percentual na região foi de 16,7%, enquanto a Região Metropolitana apresentava o menor percentual (12,3%) dentre todas as regiões (Gráfico 12 e Gráfico 13). A região Norte precisa ser ponto de atenção para o poder público, visto que o percentual de gravidezes precoces na região é significativamente mais elevado em comparação com as outras regiões.

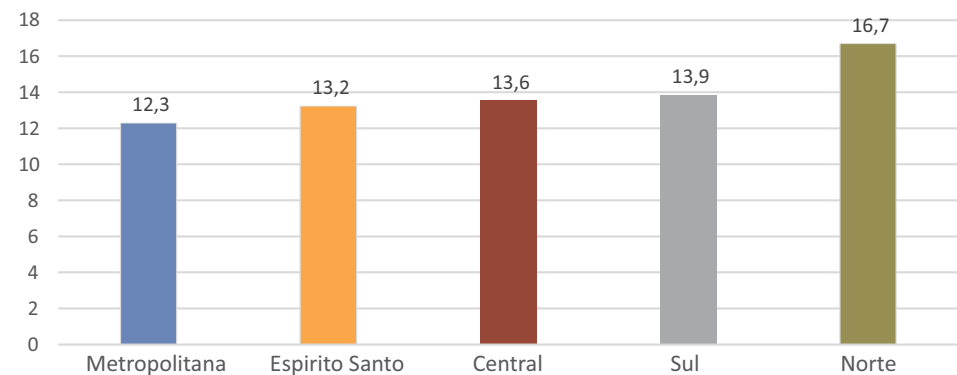
¹³ Cabe ressaltar que as regiões de saúde não seguem a divisão administrativa do estado em Microrregiões e Macrorregiões de planejamento definidas pela Lei nº 9.768 de 2011. De acordo com o Plano Diretor de Regionalização-PDR-ES (2011) a Região Norte é composta pelos seguintes municípios: Ecoporanga, Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Pedro Canário, Conceição da Barra, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Jaguaré, Boa Esperança, São Mateus. Região Central: Alto Rio Novo, Pancas, Colatina, Baixo Guandu, Marilândia, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Sooretama, Linhares, Aracruz, João Neiva, Ibatuba. Compõem a Região Metropolitana, os municípios: Itaguaçu, São Roque do Canaã, Laranja da Terra, Itarana, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Domingos Martins, Guarapari, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra, Vitória. E os municípios que fazem parte da Região Sul, são: Ibatiba, Irupi, Ibitirama, Iúna, Muniz Freire, Divino de São Lourenço, Dolores do Rio Preto, Alegre, Castelo, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataizes, Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Apicacá, Bom Jesus do Norte, Muqui, Guaçu, Divino de São Lourenço.

Gráfico 12 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Regiões da Saúde do ES, Espírito Santo, 2010-2019 (%)



Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

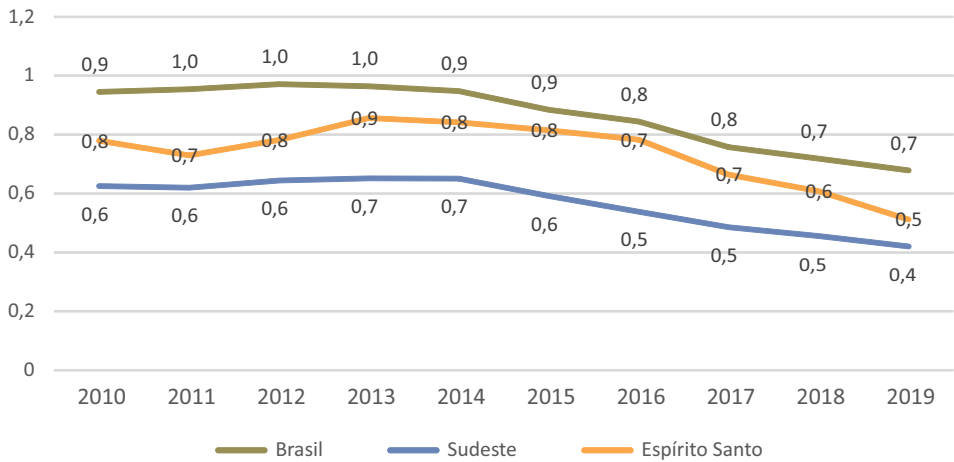
Gráfico 13 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), ES, regiões da saúde- ES, 2019 (%)



Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

De acordo com as informações elencadas no gráfico 14, a proporção de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos no ES, no período de 2010 a 2019, foi superior em relação à região Sudeste e inferior quando comparada com os dados do Brasil. Os percentuais são muito baixos, de modo que no ES e na região Sudeste não chegam nem a 1% do total de nascidos vivos em nenhum ano do período analisado. Todavia, quando os percentuais são transformados em números é possível visualizar melhor a dimensão do problema. No Brasil, no ano de 2019, estima-se que 19.330 crianças de 10 a 14 anos tornaram-se mães, enquanto na região Sudeste esses números foram de 4.636 meninas e no ES foi de 281.

Gráfico 14 – Percentual de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, Brasil, Sudeste e Espírito Santo, 2010-2019 (%)



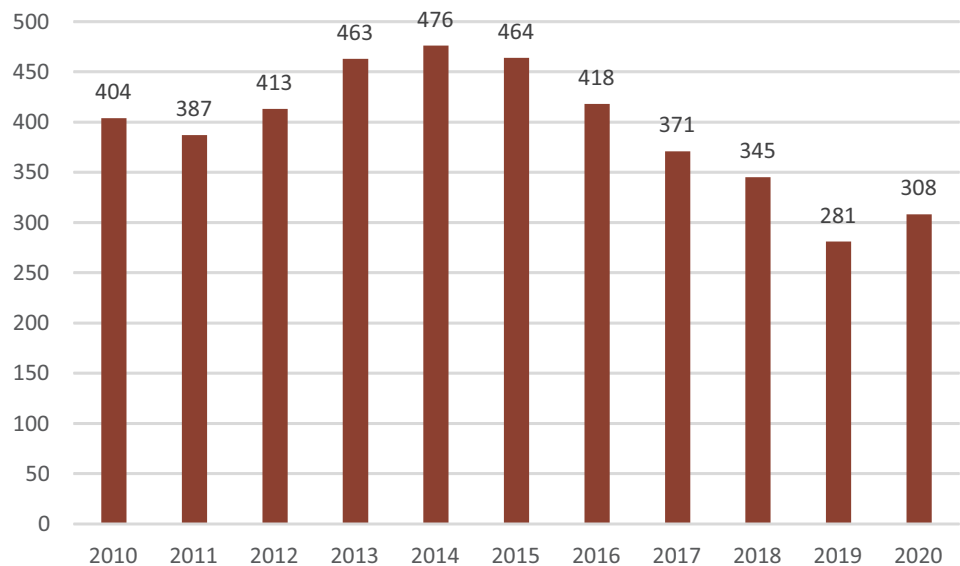
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

O gráfico 15 aponta os números absolutos de nascido vivos das meninas de 10 a 14 anos no estado do ES no período de 2010 a 2020. Nota-se que de 2011 a 2014 ocorreu um aumento no número de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos e no período de 2015 a 2019 ocorreu um decréscimo. Vale salientar que no ano de 2020 os números são maiores quando comparados ao ano de 2019, ou seja, estima-se que 27 meninas a mais tiveram bebês. Segundo o IBGE, uma menina de 14 anos ou menos “dá a luz” no ES a cada 32 horas, essa informação foi divulgada pelo jornal local “A Gazeta”¹⁴ no dia 07 de setembro de 2021. Esses dados são alarmantes e não podem ser ignorados pelo poder público e pela sociedade, de modo geral.

Não há como desconsiderar que o ano de 2020, marcado por uma série de restrições em virtude da pandemia do COVID-19, foi caracterizado pelo aumento das violações que tendem a ocorrer em âmbito doméstico, tais como a violência contra a mulher e violência sexual contra crianças e adolescentes, como já mencionado neste texto. Essa conjuntura pode ter impactado no aumento de gravidezes das meninas em relação ao ano de 2019. Para a confirmação dessa hipótese e, adicionalmente, para a formulação de políticas que visam combater esta realidade, torna-se imprescindível investigações aprofundadas a respeito da questão em destaque.

¹⁴Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/colunas/leonel-ximenes/criancas-e-adolescentes-dao-a-luz-a-cada-32-horas-no-es-0921>. Acesso em: out. 2021.

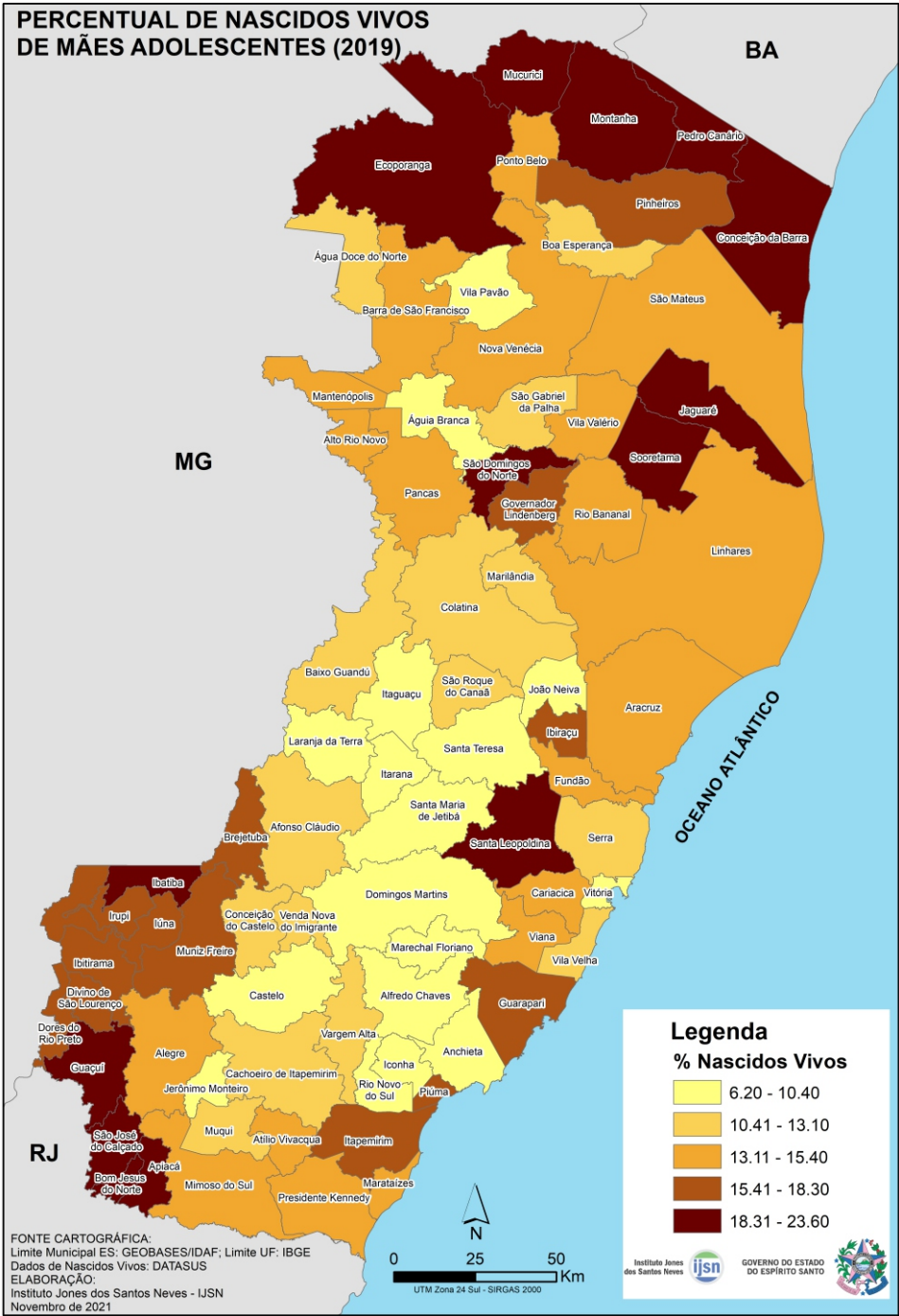
Gráfico 15 – Número de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, ES, 2010-2020



Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

O mapa 01 aponta a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes nos municípios do ES no ano de 2019. Os municípios com os percentuais mais elevados foram: Conceição da Barra (23,6%); Mucurici (23,6%); São José do Calçado (21,9%); Ibatiba (21,7%); Montanha (20,8%); Pedro Canário (20,8%); dentre outros ilustrados no mapa. Em contrapartida, os municípios com os menores percentuais de gravidez precoce no estado foram: Vila Pavão (6,2%); Laranja da Terra (7,6%); Iconha (8,1%); Rio Novo do Sul (8,3%); Domingos Martins (8,9%); Jerônimo Monteiro (9,0%), dentre outros. Os anexos 02 e 04 complementam o mapa 01 apresentando os percentuais e os números absolutos detalhados das gestações precoces de cada município do ES nos anos de 2019 e 2020.

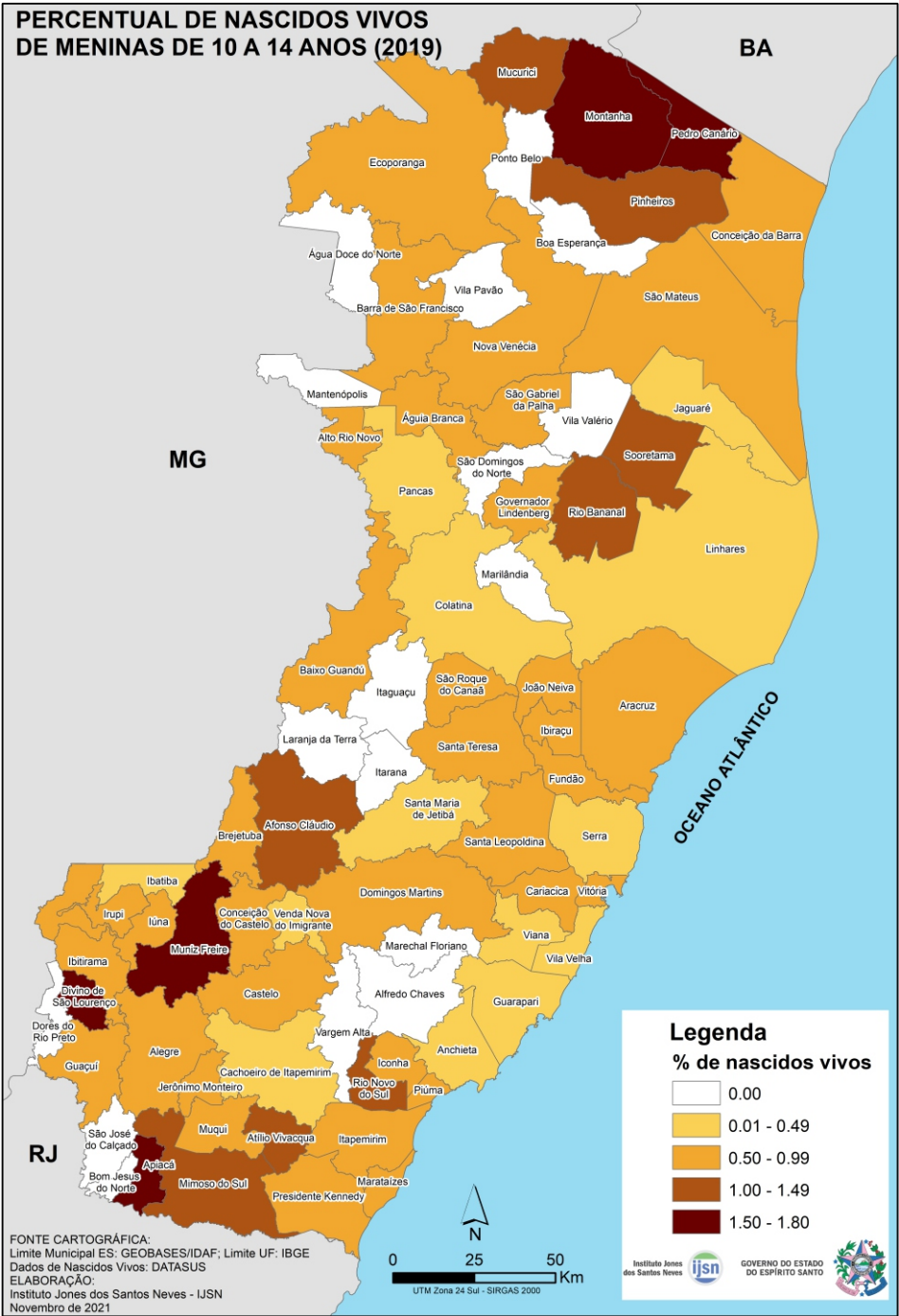
Mapa 01 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Municípios do ES, 2019 (%)



O mapa 02 aponta a proporção de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos nos municípios do ES no ano de 2019. Os municípios com os percentuais mais elevados foram: Pedro canário (1,8%); Montanha (1,5%); Apiacá (1,6%); Muniz Freire (1,5%); Divino de São Lourenço (1,7%). Em contrapartida os municípios que não tiveram nenhum nascido vivo de meninas nessa faixa etária no ano de 2019, foram: Água Doce do Norte; Alfredo Chaves; Boa Esperança; Bom Jesus do Norte; Dores do Rio Preto; Itaguaçu; Itarana; Laranja da Terra; Mantenópolis; Marechal Floriano; Marilândia; Ponto Belo; São Domingos do Norte; São José do Calçado; Vargem Alta; Vila Pavão; Vila Valério.

Os anexos 01 e 03 complementam o mapa 02 apresentando os percentuais e os números absolutos detalhados dos nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos para cada município do ES nos anos de 2019 e 2020.

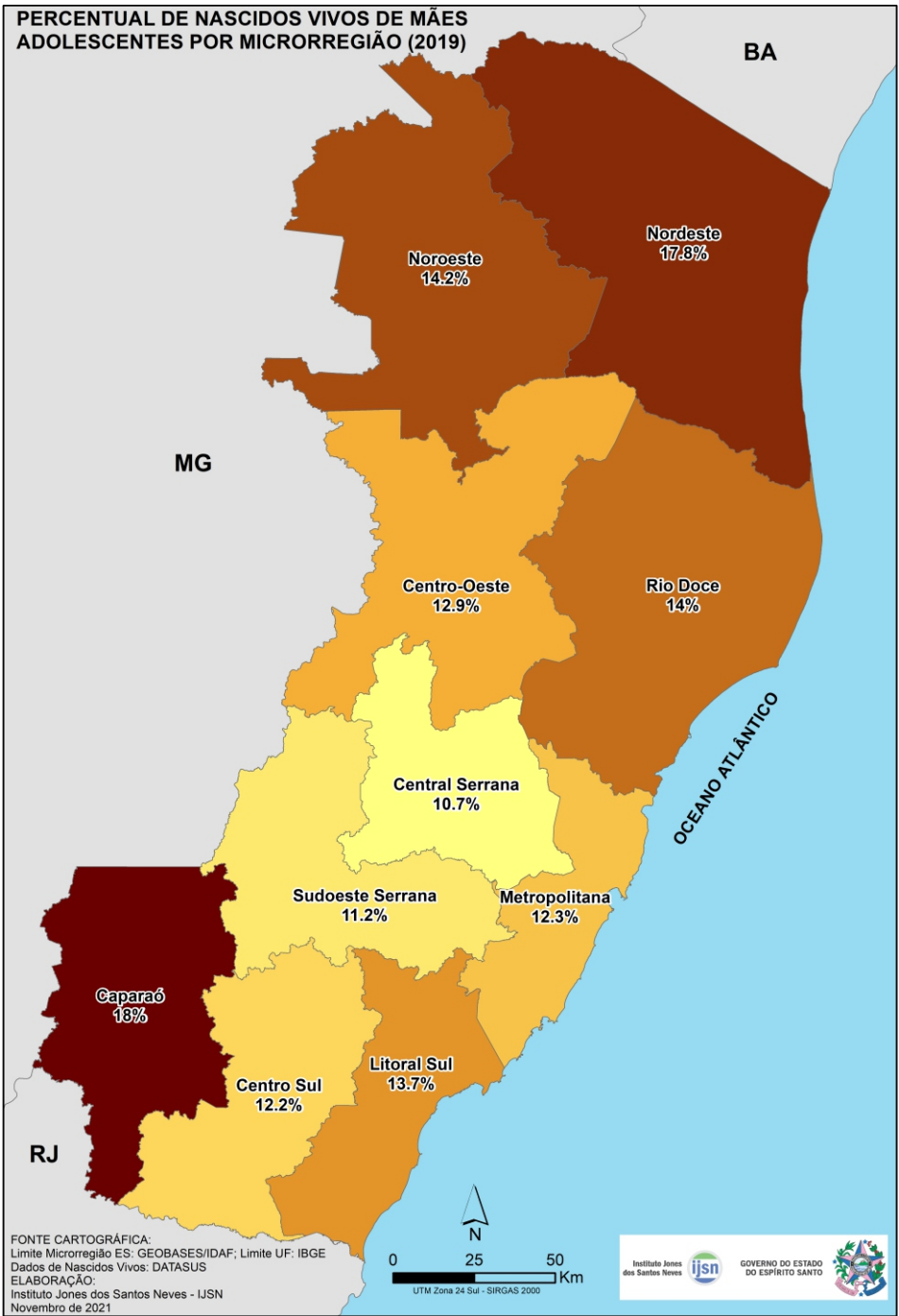
Mapa 02 – Percentual de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2019 (%)



O mapa 03 traz a distribuição do número de nascidos vivos de mães adolescentes no ano de 2019 por microrregião do ES. Observa-se que os maiores percentuais de nascidos vivos de mães adolescentes no ano de 2019 foram: Caparaó (18%), Nordeste (17,8%) e Noroeste (14,2%). Cabe mencionar que essas microrregiões são, também, as que tiveram as maiores estimativas de pobres em 2019. A microrregião do Nordeste com um percentual de 34,0%, a Noroeste com 34,5% e a micro do Caparaó com 31,9%¹⁶. Um estudo mais minucioso pode elucidar com mais consistência as possíveis correlações entre os fenômenos mencionados.

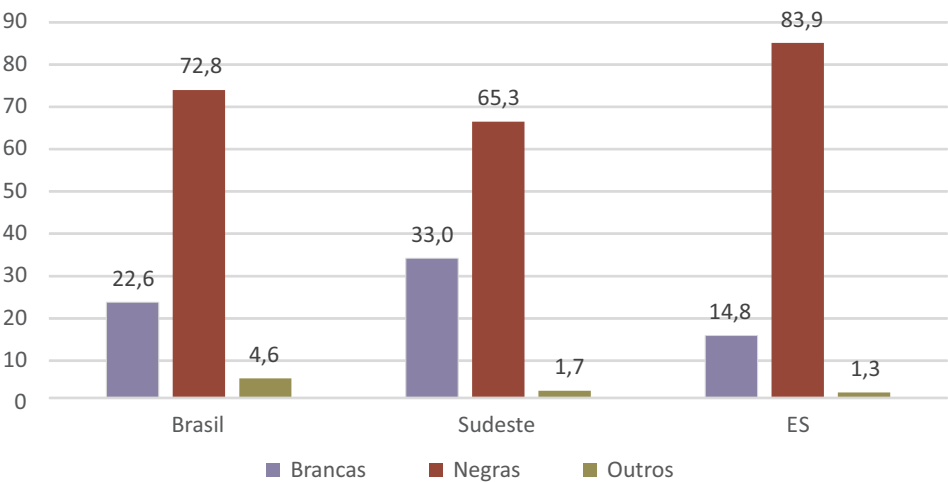
¹⁶ Conforme o Caderno DRS- 05 denominado: “Pobreza no Espírito Santo: um estudo a partir dos dados da PNADC-ANUAL e do Cadastro Único” publicado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) no ano de 2021.

Mapa 03 – Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos), Microrregiões do ES, 2019 (%)



De acordo com o gráfico 16, dentre o total de mães adolescentes no ano de 2019 a maioria eram meninas negras (pretas e pardas) tanto no Brasil (72,8%), Sudeste (65,3%) e ES (83,9%). Esses números confirmam a desigualdade racial estrutural de nossa sociedade e colocam em questão a necessidade da proposição de políticas públicas específicas para as adolescentes negras com intuito de reduzir a gravidez precoce.

Gráfico 16 – Nascidos vivos de mães adolescentes, Brasil, Sudeste e ES, por raça/cor, 2019 (%)



Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

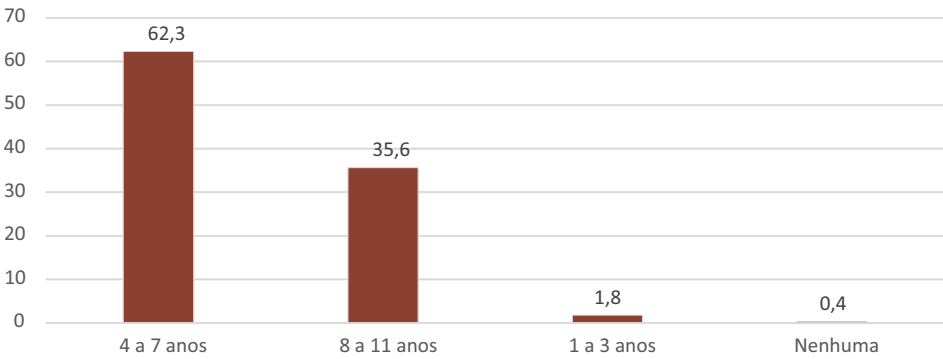
5.1 - Perfil das mães adolescentes

Esta seção visa apresentar as características das meninas mães dos nascidos vivos no ES em 2019, no que se refere à escolaridade, ao estado civil e as ocupações. E, também, apresentar informações relativas aos partos das meninas.

No que concerne à escolaridade das meninas na faixa etária de 10 a 14 anos, no ano de 2019, os dados indicam que 62,3% (175) possuíam ensino fundamental incompleto; 35,6% (100) tinham de 8 a 11 anos de estudos e 1,8% (5) tinham de 1 a 3 anos de estudos (Gráfico 17). O Ensino Fundamental é dividido em dois ciclos: os anos iniciais e anos finais que correspondem as faixas etárias de 6 a 10 anos e de 11 a 14 anos, respectivamente. A legislação presume que o ensino fundamental completo seja concluído em 9 anos. Sendo assim, caso a disponibilidade dos dados referentes à escolaridade das meninas mães considerassem os ciclos mencionados a análise do indicador tenderia a ser mais consistente e detalhada. Sobre a escolaridade das adolescentes mães de 15 a 19 anos, as informações contidas no gráfico 18 ilustram que: 71,5% (4.997) haviam estudado de 8 a 11 anos; 27,2% (1.883) de 4 a 7 anos; 1,3% (92) de 12 anos ou mais; 0,8% (53) das adolescentes tinham somente de 1 a 3 anos de estudos. Essas informações mostram uma baixa

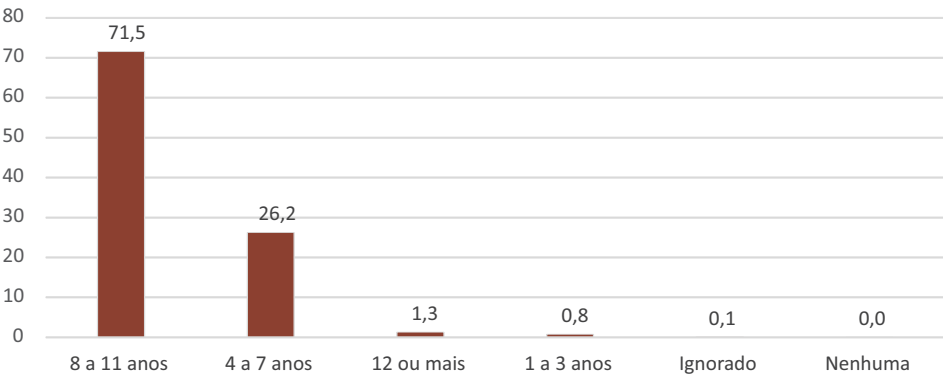
escolaridade entre as meninas que foram mães precocemente, principalmente das meninas na faixa etária de 15 a 19 anos.

Gráfico 17 – Escolaridade das meninas mães de nascidos vivos, 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Gráfico 18 – Escolaridade das mães de nascidos vivos, 15 a 19 anos, ES, 2019 (%)

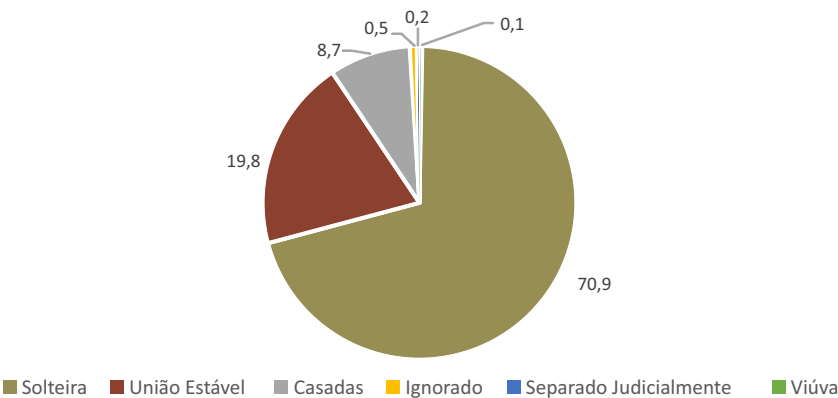


Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Sobre o estado civil das mães adolescentes (10 a 19 anos) de nascidos vivos no ES no ano de 2019 nota-se que a maioria das meninas eram solteiras (70,9%) enquanto 8,7% eram casadas e 19,8% viviam em união consensual¹⁷ (Gráfico 19). Quando a análise do estado civil é feita considerando as faixas etárias, observa-se que um total de 38 meninas de 10 a 14 anos que tiveram bebês estavam casadas (4) ou em união estável (34), conforme o gráfico 20. A princípio, parece um número relativamente baixo considerando o total de meninas dessa faixa etária que tiveram bebês. Contudo, é um dado que merece atenção e não pode ser negligenciado.

¹⁷Entende-se por união consensual quando uma pessoa vive em companhia do cônjuge sem ter contraído casamento civil ou religioso.

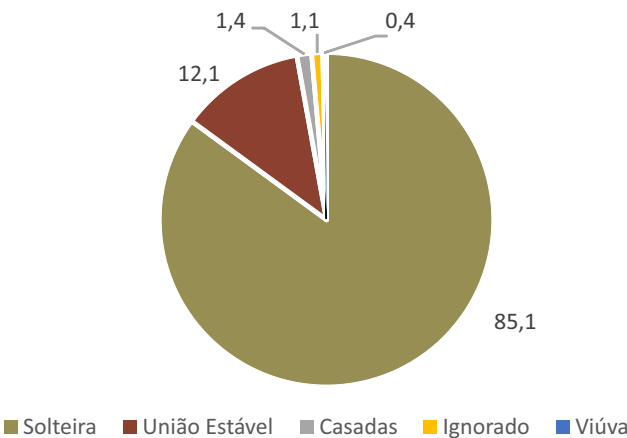
Gráfico 19 – Estado civil de mães adolescentes (10 a 19 anos) de nascidos vivos, ES, 2019 (%)*



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

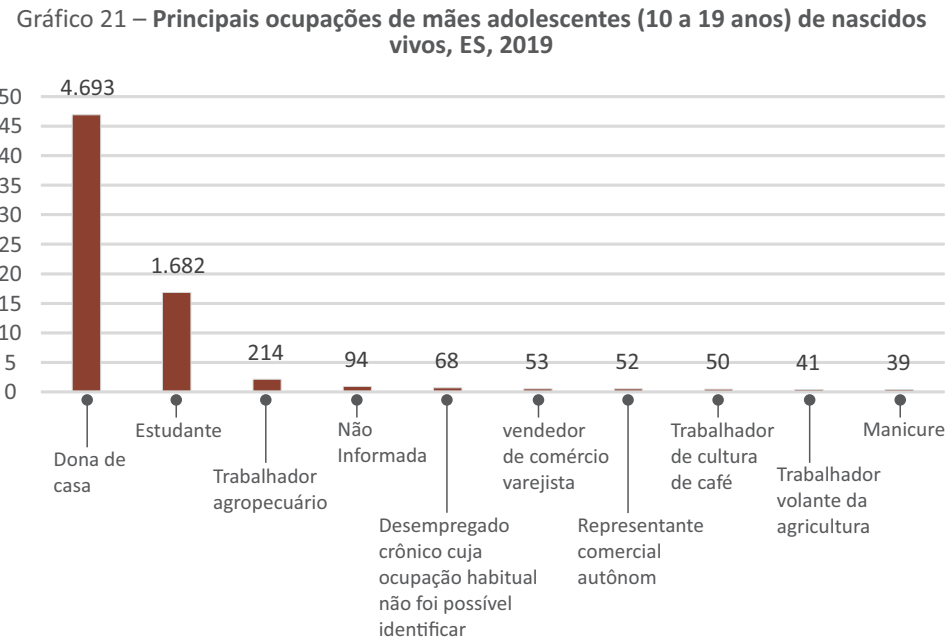
*Os outros incluem os não informados e ignorados.

Gráfico 20 – Estado civil das meninas mães, 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)

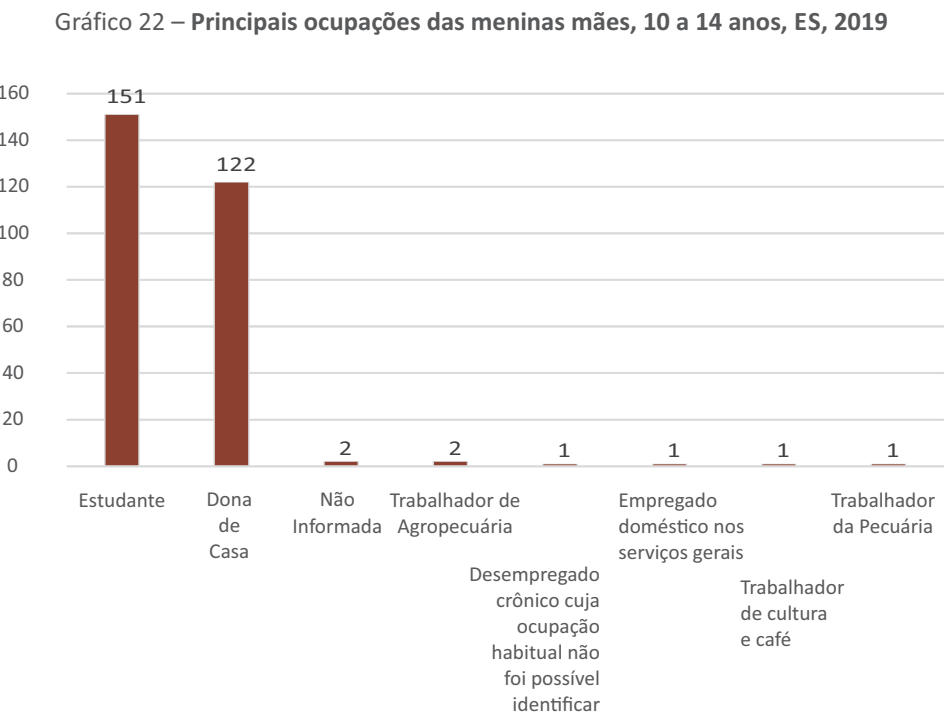


Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Os gráficos 21 e 22 sinalizam as principais ocupações das mães adolescentes no ano de 2019 no estado do ES. A maioria das meninas mães, na faixa etária de 10 a 19, eram donas de casa, o que representa um total de 4.693 meninas, seguido de estudantes (1.682); trabalhadora da agropecuária (214); não informada (94); desempregada crônica cuja ocupação habitual não foi possível identificar (68); vendedor de comercio varejista (53); representante comercial (52); dentre outros identificados no gráfico. Considerando a faixa etária das meninas de 10 a 14 anos chama atenção que 122 meninas se identificaram enquanto donas de casas. O número significativo de ocupações ligadas ao trabalho agropecuário indica uma quantidade relevante de meninas que vivem em áreas rurais.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)



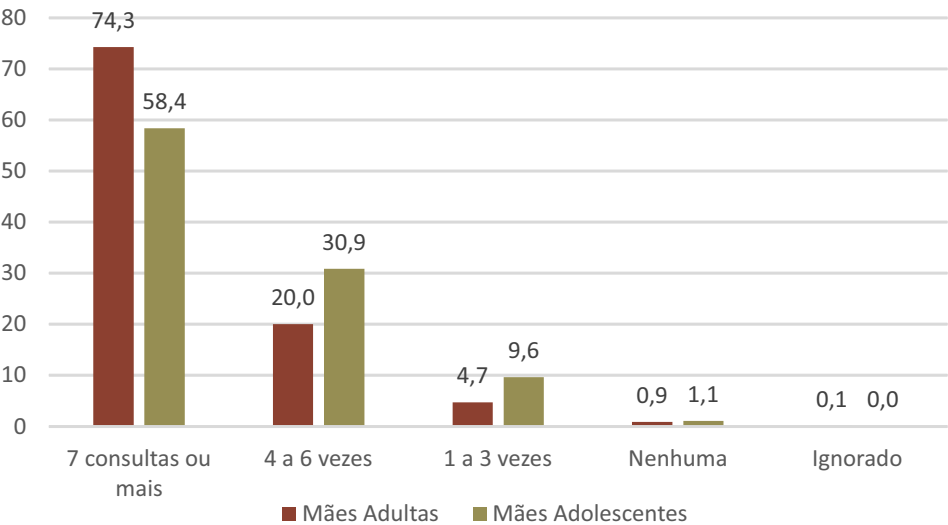
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Os gráficos 23, 24 e 25 elucidam informações referentes aos números de consultas pré-natal realizadas pelas adolescentes. A assistência pré-natal é fundamental para prevenir as possíveis complicações relacionadas à gestação e ao período neonatal, a fim de diminuir as ocorrências de morbidade e mortalidade materna e neonatal (SANTOS, et. al., 2014).

A assistência pré-natal de qualidade é importante na prevenção de riscos associados à gestação e ao período neonatal, tornando-se imprescindível o acompanhamento adequado às gestantes, às parturientes e ao neonato, a fim de identificar situações de risco precocemente, reduzindo a ocorrência de morbidade e mortalidade materna e neonatal (SANTOS, 2014, p. 720).

A Organização Mundial da Saúde recomenda, ao menos, 8 contatos de atendimento pré-natal (APN) durante a gestação. O APN é fundamental para o monitoramento da saúde da gestante e do bebê. O gráfico 23 sinaliza que o percentual de APN dos nascidos vivos de mães adultas é maior em comparação com o número de APN dos nascidos vivos de mães adolescentes. Enquanto cerca de 74,3% das mães adultas realizaram 7 ou mais atendimentos pré-natal, dentre as mães adolescentes à proporção das que realizaram esta mesma quantidade de consultas foi de 58,4% no ano de 2019. Evidencia-se que uma quantidade significativa de mães adolescentes não realizou a quantidade de consultas recomendadas pela OMS: 1,1% não realizaram nenhuma consulta; 9,3% realizaram de 1 a 3 consultas; 30,9% realizaram de 4 a 6 consultas e 58,4% realizaram o recomendado de 7 ou mais consultas (Gráfico 23).

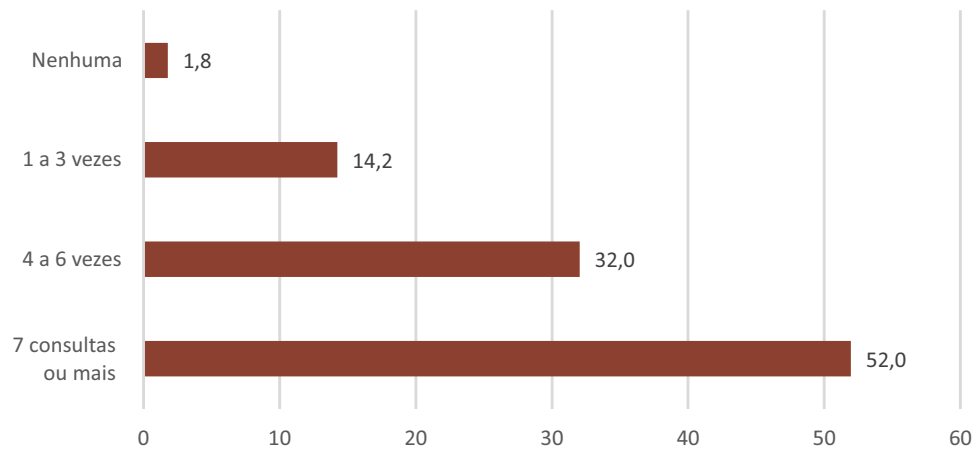
Gráfico 23 – Atendimentos pré-natal de nascidos vivos de mães adolescentes (10 a 19 anos) e de mães adultas, ES, 2019 (%)



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

O número de atendimentos pré-natal dos bebês nascidos de meninas de 10 a 14 anos é ainda menor em relação às adolescentes de 10 a 19 anos. De acordo com os dados contidos no gráfico 24: 1,8% delas não realizaram nenhuma consulta; 14,2% realizaram de 1 a 3 consultas; 32% realizaram de 4 a 6 consultas e apenas 52% realizaram o recomendado de 7 ou mais consultas.

Gráfico 24 – **Atendimentos pré-natal de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos, ES, 2019 (%)**

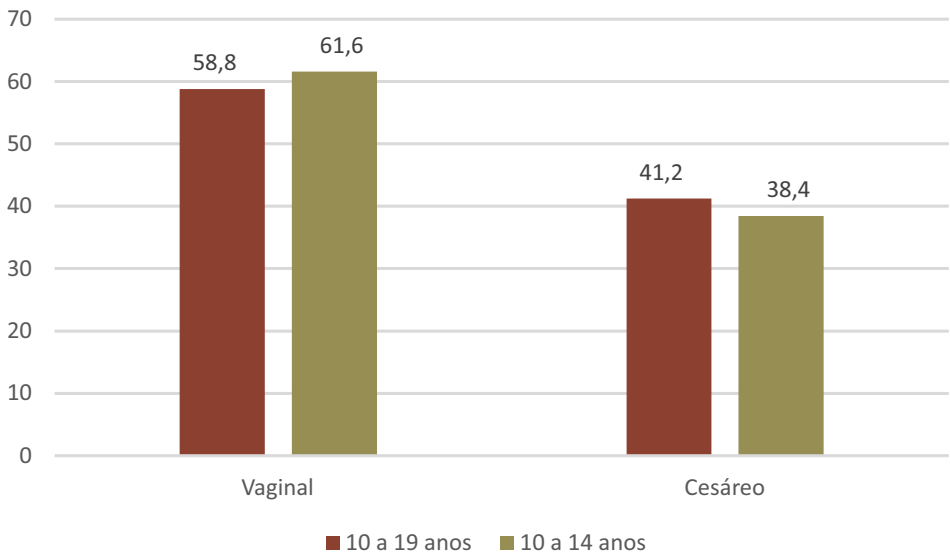


Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

O tipo de parto é um fator importante no contexto da saúde materna e neonatal. Quando as cesárias são realizadas por motivos médicos, esse tipo de parto pode diminuir a mortalidade e morbidade materna e perinatal. Contudo, quando realizadas sem necessidade podem acarretar riscos imediatos e futuros tanto para a saúde da mãe quanto para a do bebê. O gráfico 25 aponta o tipo de parto dos nascidos vivos de mães adolescentes no ES em 2019. Destaca-se que o tipo de parto predominante foi o vaginal, embora essa proporção esteja aquém do preconizado pela OMS¹⁸. Quando a análise é feita considerando as faixas etárias, nota-se que o tipo de parto de cerca de 61,6% dos bebês das meninas de 10 a 14 anos foi vaginal. Dentre as mães adolescentes de 10 a 19 anos o percentual de cesáreo foi de 58,2%. O tipo de parto cesáreo entre os nascidos vivos de mães adolescentes no ES (41,2%), no ano de 2019, é mais elevado quando comparado com o Brasil (38,4%) e com a região Sudeste (38,1%), de acordo com o gráfico 26.

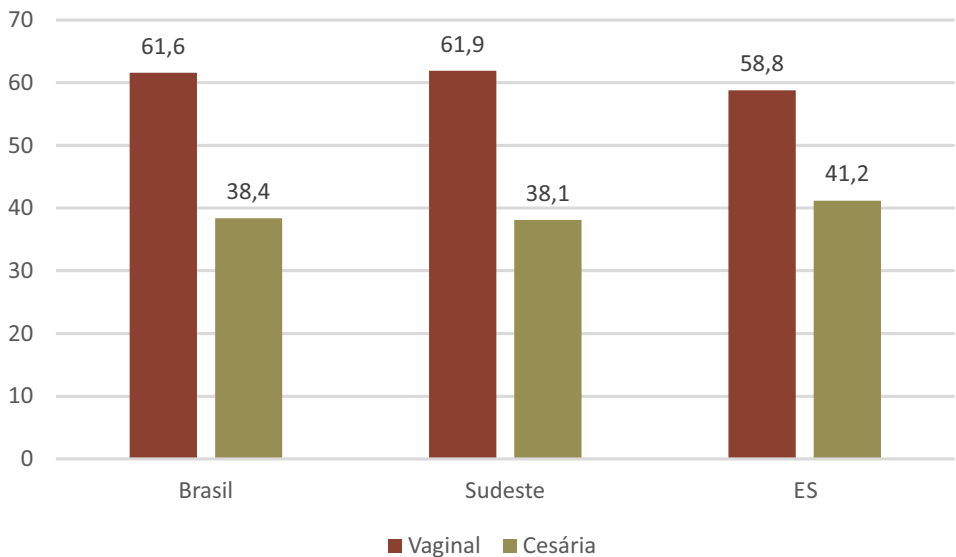
¹⁸A OMS recomenda que a taxa ideal de parto cesáreo é entre 10% a 15%.

Gráfico 25 – Tipo de parto dos nascidos vivo de mães adolescentes, por faixa etária, ES, 2019 (%)



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Gráfico 26 – Tipo de parto dos nascidos vivo de mães adolescentes, Brasil, Sudeste e ES, 2019 (%)



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

5.2 - Desafios e Perspectivas

Os direitos sexuais e reprodutivos das meninas e dos meninos adolescentes não possuem o devido reconhecimento social porque a questão da sexualidade está envolta em uma série de tabus que refletem uma cultura conservadora e moralista. Essa invisibilidade que ocorre, sobretudo, por parte das instituições familiares e religiosas limita um diagnóstico que possibilite a elaboração e efetivação de políticas públicas voltadas para atender as demandas deste grupo social (PLAN INTERNACIONAL, 2019).

Em janeiro do ano de 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) elaborou uma Política Nacional de Prevenção ao Risco da Atividade Sexual Precoce em que propôs a abstinência (ou adiamento da vida sexual) como política pública para o enfrentamento da gravidez na adolescência¹⁹. Corroborar-se com a perspectiva de Cabral e Brandão (2020) quando os autores afirmam que a abstinência sexual ou o adiamento do início da vida sexual é uma alternativa legítima, entretanto é uma opção de cunho pessoal e privado. Sendo assim, considerando a elaboração de políticas públicas em um Estado democrático e laico que considera as evidências científicas para embasar as políticas, a premissa de abstinência sexual e/ou adiamento do início da vida sexual são aspectos que não contribuem para amenizar a realidade discutida neste texto, pois não apresentam evidências científicas relacionadas a diminuição das gestações precoces.

O enfrentamento da gravidez entre as adolescentes e da diminuição da incidência de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis perpassa pela educação sexual. A formulação de políticas públicas que garantam educação sexual precisa abordar sobre a sexualidade sem moralismos e propiciar aos adolescentes informações qualificadas. Nesse viés é primordial que os profissionais que lidam com esse segmento populacional, seja da saúde ou da educação, estejam abertos ao diálogo.

As gravidezes imprevistas não se restringem ao segmento populacional adolescente e é uma realidade também na vida de pessoas adultas. Esse cenário revela a necessidade de políticas públicas que focalizem a complexidade do exercício da contracepção, uma vez que informações qualificadas e acessos aos métodos não são suficientes para evitar as gravidezes, como salientam Cabral e Brandão (2020, p. 03):

¹⁹ A Câmara de Vitória, capital do ES, aprovou, em novembro de 2021, o projeto que prevê abstinência sexual contra gravidez precoce. Segundo a reportagem de A Gazeta, publicada no dia 10 de novembro de 2021, o projeto chamado de “Eu Escolhi Esperar” tem objetivo de prevenir a gravidez precoce na Capital, contudo o texto não explicita quais medidas devem ser tomadas. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/politica/camara-de-vitoria-aprova-projeto-eu-escolhi-esperarcontra-gravidez-precoce-1121>. Acesso em: nov. 2021.

Uma política pública voltada ao exercício responsável da sexualidade na adolescência e ao enfrentamento da desigualdade de gênero, em qualquer pasta ministerial, precisa contemplar o fortalecimento da escolarização, da autonomia pessoal, da capacidade dos adolescentes refletirem sobre suas escolhas afetivas e/ou sexuais, conhecerem e tomarem medidas de proteção à saúde, como uso do preservativo, dos métodos contraceptivos regulares ou de longa duração, da contracepção de emergência, do acesso ao aborto legal, além do combate às discriminações de gênero, ao racismo, ao machismo, à homofobia, à transfobia. Esses são elementos imprescindíveis para a construção da autonomia juvenil e para o exercício da sexualidade com base na perspectiva do reconhecimento da alteridade e dos direitos humanos.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) sinaliza que existe várias críticas ao Programa americano que orienta a abstinência sexual até o casamento como forma de evitar as gravidezes precoces, tanto por causa do alto custo do Programa como pela ineficácia. A SBP se posiciona de forma crítica a respeito dessa perspectiva que defende a abstinência sexual pontuando as falhas científicas e éticas. Nas palavras de Cabral e Brandão (2020, p. 3): “[...] o infeliz atalho do aconselhamento pela abstinência sexual não ocultará que o problema, de fato, não se restringe às 'gravidezes precoces', mas o que elas nos revelam como sintomas de abandono e indiferença social com segmentos excluídos do país.”

O Sistema Único de Saúde (SUS) alinhado com as premissas do ECA e do Ministério da Saúde reconhece que na abordagem da adolescência é primordial reconhecer os direitos que esse grupo tem em relação a importância de conhecer seu próprio corpo e receber informações qualificadas sobre os direitos sexuais e reprodutivos.

A educação sexual integrada e abrangente faz parte da promoção do bem-estar dos adolescentes e jovens, realçando o comportamento sexual responsável, o respeito pelo/a outro/a, a igualdade e equidade de gênero, assim como a proteção da gravidez inoportuna, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e Aids, defesa contra violência sexual incestuosa e outras violências e abusos (CABRAL; BRANDÃO, 2021, p. 3).

À vista disso, a prevenção da gravidez precoce perpassa, fundamentalmente, pela educação com uma abordagem científica. É importante que a educação, tanto no âmbito familiar quanto da escola, contemple aspectos da sexualidade e da saúde reprodutiva. Além disso, faz-se necessário que as políticas e os programas de saúde direcionados à população adolescente compreenda esse segmento de forma integral a partir de suas singularidades, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

É importante que a escola e os serviços de saúde façam um trabalho integrado, de forma que possam criar uma rede de proteção. Nessa direção é fundamental que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) também acolham e apoiem as ações educativas que visam o planejamento reprodutivo, as consultas pré-natal e as consul-

tas após o parto para que as adolescentes sejam atendidas em suas particularidades com vistas à proteção e à promoção da saúde sexual e reprodutiva. A legislação assevera que os serviços de saúde devem garantir um atendimento no planejamento reprodutivo antes mesmo das meninas e dos meninos iniciarem a vida sexual, com a finalidade de ajudá-los a lidarem com a sexualidade de maneira positiva e responsável.

Produzir saúde com adolescentes e jovens é considerar seus projetos de vida, é valorizar sua participação e o desenvolvimento de sua autonomia, é acreditar que eles e elas aprendem a lidar com os seus problemas e com seu contexto de vida tendo o apoio e a corresponsabilidade dos trabalhadores da saúde, sem moralismos, controle e opressão. É promover a participação desse grupo populacional em redes intersetoriais que lhes garanta proteção e a garantia de seus direitos. É trazê-los para o centro do processo como sujeitos de direitos (BRASIL, 2010a. p. 39).

Por fim, ressalta-se que a atenção básica é um local privilegiado para a prevenção do problema, uma vez que têm contato com uma quantidade expressiva de meninas e, logo, pode reconhecer e acolher casos de violência sexual ou mesmo de gravidezes de forma mais precocemente possível. É consenso entre estudiosos da temática que um dos desafios da área da saúde é superar a fragmentação e assegurar a atenção integral. Ademais, fornecer as informações necessárias para que as meninas e familiares tenham conhecimento acerca de seus direitos no que diz respeito à interrupção da gravidez, por exemplo.

Considerações Finais

Este texto buscou contribuir para o debate referente à gravidez na adolescência. Desse modo, apresentou uma breve revisão bibliográfica acerca do assunto em voga além de dados que mostram algumas dimensões do fenômeno no estado do Espírito Santo e, quando preciso, no Brasil e na Região Sudeste.

O texto enunciou que a gestação precoce não é um acontecimento homogêneo, mas sim um evento abrangente e multicausal. Para que esse fenômeno possa ser compreendido é necessário considerar os valores culturais dos meios em que as adolescentes transitam, os papéis de gênero, as desigualdades de classe e raça. Logo, em relação aos aspectos que predis põem o aumento de gravidezes precoces predominam-se questões sociais, econômicas, culturais, de gênero, dificuldades de acesso a planejamento familiar, dentre outros.

Diante disso, destacou-se duas principais abordagens que têm sido realizadas pela literatura sobre a gestação precoce: gravidez na adolescência enquanto um problema social e de saúde pública e como uma experiência desejada pelas adolescentes em decorrência do contexto sociocultural ao qual elas se inserem.

As gestações precoces são consideradas enquanto um problema de saúde pública porque as mães adolescentes são mais propensas às complicações de saúde durante e após a gestação. Os bebês recém-nascidos também tendem a apresentar maiores problemas relacionados à saúde. O fenômeno é um problema social por causa dos possíveis impactos sociais negativos gerados na trajetória de vida das meninas e dos meninos que se tornam pais, tais como o abandono escolar e a reprodução do ciclo da pobreza.

Buscou-se apontar assuntos correlatos a temática proposta neste texto, como o casamento precoce e a violência sexual. O casamento ou as uniões precoces geram barreiras nas trajetórias de vida das meninas, sobretudo, em relação às dimensões educacionais, profissionais e subjetivas, como um todo. Não ignorando a amplitude do fenômeno, observa-se que uma das consequências do casamento precoce transcorre da gravidez precoce. E que, por outro lado, as formações familiares precoces também contribuem para as gestações na fase da adolescência.

O texto destaca a importância de analisar a gravidez precoce considerando as especificidades das gravidezes das meninas de 10 a 14 anos. Entende-se que as gestações de meninas dessa faixa etária são provenientes de violência sexual, uma vez que a legislação preconiza que as relações sexuais ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos são consideradas crime sexual contra vulnerável, independente da comprovação de discernimento ou não para o consentimento da vítima.

Chama atenção que no período de 2015 a 2019 o número de nascidos vivos de meninas de 10 a 14 anos no ES diminuiu, contudo em 2020 nota-se um aumento em re-

lação ao ano anterior. Em 2020, cerca de 308 crianças foram mães no Espírito Santo. Esse dado é extremamente preocupante e, portanto, não pode ser negligenciado.

Outra questão que cabe ressaltar é que no ano de 2020 o estado do ES registrou, em média, três estupros de crianças e adolescentes por dia. Reforça-se que não há como negligenciar que o contexto de restrições ocasionadas por causa da pandemia do COVID-19 contribuiu para o aumento da violência sexual contra as crianças e os adolescentes.

Além disso, enquanto na maior parte dos estados brasileiros os registros de estupros reduziram, no ES os números ampliaram, de acordo com a pesquisa realizada pela UNICEF em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A Rede Feminista de Saúde pontuou cinco propostas que podem contribuir para o combate ao estupro presumido de meninas e o cuidado das que vivenciam esta violência, que foram: dimensionamento e acompanhamento das meninas de até 14 anos que engravidaram; integração dos serviços de atenção à saúde às vítimas sobreviventes de estupro; divulgação dos serviços de referência para atenção à violência sexual e para o aborto legal, além da facilitação do acesso a eles; composição de redes de proteção e planejamento intersetorial; medidas preventivas em escolas, famílias e comunidades.

Para que essa realidade seja amenizada faz-se necessário políticas públicas que garantam os direitos sexuais e reprodutivos a essas adolescentes e seus parceiros. São vários fatores que interferem para a gravidez precoce, todavia a desinformação sobre a sexualidade é uma das dimensões fundamentais nesse contexto. Dessa maneira, a educação sexual juntamente com profissionais competentes é o meio possível de evitar uma gravidez não planejada e, além disso, contribuir para prevenção de ISTs.

Destaca-se que há obstáculos das políticas públicas em garantir os direitos sexuais e reprodutivos aos adolescentes, tanto pelo conservadorismo cultural vigente na sociedade que negligencia a vivência sexual das meninas e meninos nos primeiros anos da adolescência ou mesmo pela deficiência dos serviços de saúde, educação e assistência social.

Vale ressaltar que a abstinência sexual enquanto proposta de política pública para mitigar a gravidez na adolescência é uma falácia que em nada colabora para tal. Não há evidências científicas que mostrem que essa proposta tem resultados eficazes. Pelo contrário, essa perspectiva reforça uma lógica conservadora que ignora o fato de que as/os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e, dessa forma, possibilita que a educação sexual não seja garantida nos espaços educativos. É fundamental, portanto, a realização de pesquisas e estudos sobre a temática com o intuito de subsidiar as políticas públicas voltadas para o enfrentamento das gravidezes precoces.

Referências

BRASIL. **Constituição Federal do Brasil**. Brasília: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: ago. 2021.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: set. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf. Acesso em: set. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica [recurso eletrônico]** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf. Acesso em: ago. 2021.

BRASIL. Lei 13.798, de 03 de janeiro de 2019. Acrescenta artigo 8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. **Diário Oficial da União**, Brasília, 03. Jan. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13798.htm. Acesso em: out. 2020.

CABRAL, Cristiane; BRANDÃO, Elaine. Gravidez na adolescência, iniciação sexual e gênero: perspectivas em disputa. **Cad. Saúde Pública**, 36(8), 2020.

CASTRO, Mary; ABRAMOVAY, Miriam; SILVA, Lorena. **Juventudes e Sexualidade**. UNESCO: Brasília, 2014.

CAVENAGHI, Suzane.; ALVES, D. A diversidade do comportamento reprodutivo de adolescentes e jovens no Brasil. In: **X Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos - X ENABER.**, 2012, Recife. Anais do X ENABER. São Paulo: ABER, v. 1. 2014.

CERQUEIRA, Daniel; COELHO, Danilo. Nota Técnica nº 11. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde. Brasília: **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)**: 2014.

DIAS, Ana Cristina; TEIXEIRA, Marco. Gravidez na adolescência: um olhar sobre

um fenômeno complexo. **Paideia**, Vol. 20. n° 45, 123-131, 2010.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Pesquisa Nacional de Saúde do escolar. Rio de Janeiro, 2021. Coordenação de População e Indicadores Sociais.

INDICA. Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente. **Gravidez na Adolescência no Brasil** - Vozes de Meninas e de Especialistas, Brasília, 2017. Disponível em: http://unfpa.org.br/Arquivos/br_gravidez_adolescencia_2017.pdf. Acesso em: set. 2021.

IFAN. Rede Nacional da Primeira Infância/RNPI: **Primeira Infância e gravidez na adolescência**. Fortaleza, 2014. Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Cartilha-Gravidez-Adol-FINAL-HD.pdf>. Acesso em: set. 2021.

LOSS, Maria; SAPIRO, Clary. Processos psíquicos do engravidamento na adolescência em contexto de periferia: Impasses e possibilidades. **Psicologia USP**, 16(4), 69-98, 2005.

MARTINS, Paulo; VERONA, Ana Paula. Mudanças na fecundidade adolescente segundo escolaridade entre 1991 e 2010 no Brasil: os diferenciais se alteram ao longo do tempo? **Revista Latinoamericana de Población**, Vol. 13. n° 25, 2019.

MICHELAZZO, D; et.al., Indicadores sociais de grávidas adolescentes: estudo caso-controle. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.** [on-line]. 26 (8). 2004.

MIURA, Paula; TARDIVO, Leila; BARRIENTOS, Dora. O desamparo vivenciado por mães adolescentes e adolescentes grávidas acolhidas institucionalmente. **Ciência & Saúde Coletiva**, 23 (5): 1601-1610, 2018.

MORAES-PARTELLI, Adriana; COELHO, Marta; FREITAS, Paula; Gravidez não-planejada em comunidades quilombolas: percepção dos adolescentes. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 30, 2021.

NASCIMENTO, Thiago Luis; TEIXEIRA, Camila Silveira; ANJOS, Marília, et al., Fatores associados à variação espacial da gravidez na adolescência no Brasil, 2014: estudo ecológico de agregados espaciais. **Epidemiol. Serv. Saude**, Brasília, 30(1), 2021.

NOVELLINO, Maria Salete. Um estudo sobre as mães adolescentes brasileiras. **Physis Rev Saúde Colet**. 2011; 21(1): 299-318.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Nações Unidas Brasil. **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**. Brasília, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: jul. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). **A situação da população mundial 2018**: o poder de escolha - direitos reprodutivos e a transição demográfica. Brasília, 2018. Disponível

em: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP_2018.pdf. Acesso em: out. 2021.

PANTOJA, Ana Lúcia. “Ser alguém na vida”: uma análise sócio-antropológica da gravidez/maternidade na adolescência, em Belém do Pará, Brasil. **Cad. Saúde Pública** 19 (supl 2) 2003.

PLAN INTERNACIONAL BRASIL. **Tirando o véu: estudo sobre o casamento infantil no Brasil**. 2019.

REIS, Alberto; OLIVEIRA-MONTEIRO, Nancy. Sexualidade e procriação na ótica de jovens de periferias sociais e urbanas. **Rev. Bras. Crescimento Desenv. Hum** 2007; 17(2):54-63.

SABROZA, Adriane; LEAL, Maria. et. al., Algumas repercussões emocionais negativas da gravidez precoce em adolescentes do município do Rio de Janeiro (1999-2001). **Cad Saúde Pública**. 2004; 20(sup.1).

SALLES, Leila Maria. Infância e adolescência na sociedade moderna: alguns apontamentos. **Estudos de Psicologia** | Campinas | 22(1) | 33-41 | janeiro - março. 2005.

SANTOS, Cristiane; NOGUEIRA, Kátia. Gravidez na adolescência: falta de informação? **Adolescência & Saúde**, v. 6, n. 1, p. 48-56, 2009.

SANTOS, Nilma; COSTA, Maria; AMARAL, Magali. et. al., Gravidez na adolescência: análise de fatores de riscos para baixo peso, prematuridade e cesariana. **Ciência & Saúde Coletiva**, 19 (3): 719-726, 2014.

SOUTO, Rayone; PORTO, Denise. et al., Estupro e gravidez de meninas de até 13 anos no Brasil: características e implicações na saúde gestacional, parto e nascimento. **Ciência & Saúde Coletiva** 22 (9) Set 2017.

UNICEF. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. **Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil**. Brasília, 2021.

UNFPA. Fundo Populacional das Nações Unidas. **Situação da População Mundial- Maternidade precoce: enfrentando o desafio da gravidez na adolescência**. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/swop2013.pdf>. Acesso em: set. 2021.

VIEGAS, Paulo; VERONA, Ana. Mudanças na fecundidade adolescente segundo escolaridade entre 1991 e 2010 no Brasil: os diferenciais se alteram ao longo do tempo? **RELAP - Revista Latinoamericana de Población**. Vol. 13 - Número 25: 54-71, 2019.

Anexos

Anexo 1 – Nascidos Vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2019

Municípios	%	Números absolutos
Afonso Cláudio	1,1	4
Água Doce do Norte	-	0
Água Branca	0,8	1
Alegre	0,5	2
Alfredo Chaves	-	0
Alto Rio Novo	1,0	1
Anchieta	0,3	1
Apiacá	1,6	1
Aracruz	0,6	9
Atilio Vivacqua	1,3	2
Baixo Guandu	0,5	2
Barra de São Francisco	0,8	5
Boa Esperança	-	0
Bom Jesus do Norte	-	0
Brejetuba	0,8	2
Cachoeiro de Itapemirim	0,3	8
Cariacica	0,5	30
Castelo	0,5	2
Colatina	0,4	7
Conceição da Barra	0,7	3
Conceição do Castelo	0,6	1
Divino de São Lourenço	1,7	1
Domingos Martins	0,6	3
Dores do Rio Preto	-	0
Ecoporanga	1,0	3
Fundão	0,7	2
Governador Lindenberg	0,8	1
Guaçuí	1,0	4
Guarapari	0,4	7
Ibatiba	0,3	1
Ibiraçu	0,5	1
Ibitirama	0,7	1
Iconha	0,7	1
Irupi	0,5	2
Itaguaçu	-	0
Itapemirim	0,5	3
Itarana	-	0
Lúna	1,0	4
Jaguaré	0,4	2

Continua

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 1 – Nascidos Vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2019

Continuação

Municípios	%	Números absolutos
Jerônimo Monteiro	0,7	1
João Neiva	0,6	1
Laranja da Terra	-	0
Linhares	0,3	7
Mantenópolis	-	0
Marataizes	0,7	4
Marechal Floriano	-	0
Marilândia	-	0
Mimoso do Sul	1,1	3
Montanha	1,5	4
Mucurici	1,4	1
Muniz Freire	1,5	3
Muqui	0,6	1
Nova Venécia	0,6	4
Pancas	0,4	1
Pedro Canário	1,8	7
Pinheiros	1,1	4
Piúma	0,6	2
Ponto Belo	-	0
Presidente Kennedy	0,5	1
Rio Bananal	1,4	4
Rio Novo do Sul	1,3	2
Santa Leopoldina	0,8	1
Santa Maria de Jetibá	0,4	3
Santa Teresa	0,7	2
São Domingos do Norte	-	0
São Gabriel da Palha	0,7	3
São José do Calçado	-	0
São Mateus	0,6	10
São Roque do Canaã	0,9	1
Serra	0,4	30
Sooretama	1,1	5
Vargem Alta	-	0
Venda Nova do Imigrante	0,3	1
Viana	0,3	3
Vila Pavão	-	0
Vila Valério	-	0
Vila Velha	0,4	29
Vitória	0,6	28

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 2 – Nascidos Vivos de mães adolescentes, Municípios do ES, 2019

Municípios	%	Números absolutos
Afonso Cláudio	11,6	44
Água Doce do Norte	12,6	24
Águia Branca	10,4	13
Alegre	13,2	51
Alfredo Chaves	9,7	15
Alto Rio Novo	15,0	15
Anchieta	9,9	39
Apiacá	19,0	12
Aracruz	13,3	201
Atílio Vivacqua	14,1	21
Baixo Guandu	12,3	49
Barra de São Francisco	15,2	97
Boa Esperança	13,0	24
Bom Jesus do Norte	19,5	17
Brejetuba	16,2	39
Cachoeiro de Itapemirim	12,2	312
Cariacica	14,4	812
Castelo	10,3	45
Colatina	12,0	189
Conceição da Barra	23,6	96
Conceição do Castelo	12,8	23
Divino de São Lourenço	17,2	10
Domingos Martins	8,9	45
Dores do Rio Preto	16,9	14
Ecoporanga	18,9	54
Fundão	14,2	38
Governador Lindenberg	15,8	21
Guaçuí	19,9	83
Guarapari	16,0	287
Ibatiba	21,7	86
Ibiraçu	16,3	31
Ibitirama	17,6	24
Iconha	8,3	11
Irupi	18,3	40
Itaguaçu	10,0	14
Itapemirim	18,0	111
Itarana	9,8	11
Lúna	15,7	60
Jaguaré	19,3	92

Continua

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 2 – Nascidos Vivos de mães adolescentes, Municípios do ES, 2019

Continuação

Municípios	%	Números absolutos
Jerônimo Monteiro	9,0	13
João Neiva	9,9	17
Laranja da Terra	7,6	9
Linhares	13,7	346
Mantenópolis	15,4	25
Marataizes	13,3	76
Marechal Floriano	9,8	22
Marilândia	12,3	21
Mimoso do Sul	14,0	39
Montanha	20,8	56
Mucurici	23,6	17
Muniz Freire	17,6	46
Muqui	13,1	22
Nova Venécia	13,3	96
Pancas	13,4	32
Pedro Canário	20,8	79
Pinheiros	18,2	68
Piúma	17,2	58
Ponto Belo	14,3	11
Presidente Kennedy	14,3	31
Rio Bananal	13,3	39
Rio Novo do Sul	8,31	13
Santa Leopoldina	9,5	23
Santa Maria de Jetibá	9,8	67
Santa Teresa	1,0	30
São Domingos do Norte	0,1	22
São Gabriel da Palha	19,6	53
São José do Calçado	12,8	28
São Mateus	22,0	279
São Roque do Canaã	15,4	13
Serra	11,8	953
Sooretama	12,4	84
Vargem Alta	18,9	32
Venda Nova do Imigrante	11,6	42
Viana	11,7	14
Vila Pavão	13,7	7
Vila Valério	6,2	6
Vila Velha	14,8	34
Vitória	10,8	700
	9,8	441

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 3 – Nascidos Vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2020

Municípios	%	Números absolutos
Afonso Cláudio	1,5	6
Água Doce do Norte	0,5	1
Águia Branca	-	0
Alegre	0,3	1
Alfredo Chaves	-	0
Alto Rio Novo	-	0
Anchieta	0,5	2
Apiacá	1,4	1
Aracruz	0,3	4
Atílio Vivacqua	-	0
Baixo Guandu	0,5	2
Barra de São Francisco	0,6	4
Boa Esperança	0,9	2
Bom Jesus do Norte	-	0
Brejetuba	1,0	2
Cachoeiro de Itapemirim	0,5	13
Cariacica	0,4	23
Castelo	0,2	1
Colatina	0,5	8
Conceição da Barra	-	0
Conceição do Castelo	0,6	1
Divino de São Lourenço	1,5	1
Domingos Martins	0,4	2
Dores do Rio Preto	1,3	1
Ecoporanga	0,3	1
Fundão	0,8	2
Governador Lindenberg	-	0
Guaçuí	0,7	3
Guarapari	0,8	15
Ibatiba	-	0
Ibiraçu	1,9	3
Ibitirama	-	0
Iconha	-	0
Irupi	1,1	2
Itaguaçu	0,7	1
Itapemirim	0,2	1
Itarana	-	0
Lúna	-	0
Jaguareé	0,4	2

Continua

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 3 – Nascidos Vivos de meninas de 10 a 14 anos, Municípios do ES, 2020

Continuação

Municípios	%	Números absolutos
Jerônimo Monteiro	-	0
João Neiva	0,5	1
Laranja da Terra	-	0
Linhares	1,0	26
Mantenópolis	2,2	4
Marataizes	0,7	4
Marechal Floriano	-	0
Marilândia	0,7	1
Mimoso do Sul	1,0	3
Montanha	0,4	1
Mucurici	-	0
Muniz Freire	0,4	1
Muqui	-	0
Nova Venécia	0,6	4
Pancas	-	0
Pedro Canário	1,6	5
Pinheiros	2,8	10
Piúma	0,6	2
Ponto Belo	-	0
Presidente Kennedy	0,9	2
Rio Bananal	1,4	4
Rio Novo do Sul	0,8	1
Santa Leopoldina	0,8	1
Santa Maria de Jetibá	0,2	1
Santa Teresa	0,3	1
São Domingos do Norte	1,0	1
São Gabriel da Palha	1,1	5
São José do Calçado	-	0
São Mateus	0,8	15
São Roque do Canaã	0,9	1
Serra	0,6	46
Sooretama	0,7	3
Vargem Alta	0,8	2
Venda Nova do Imigrante	0,9	3
Viana	0,2	2
Vila Pavão	-	0
Vila Valério	1,3	3
Vila Velha	0,4	25
Vitória	0,6	25

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 4 – Nascidos Vivos de mães adolescentes, Municípios do ES, 2020

Municípios	%	Números absolutos
Afonso Cláudio	12,9	51
Água Doce do Norte	11,5	21
Águia Branca	12,4	16
Alegre	11,2	42
Alfredo Chaves	7,9	10
Alto Rio Novo	11,1	10
Anchieta	10,0	42
Apiacá	12,2	9
Aracruz	13,8	201
Atílio Vivacqua	17,1	26
Baixo Guandu	10,3	40
Barra de São Francisco	12,2	78
Boa Esperança	17,8	38
Bom Jesus do Norte	9,3	7
Brejetuba	24,0	50
Cachoeiro de Itapemirim	11,9	301
Cariacica	13,7	744
Castelo	9,2	41
Colatina	12,1	193
Conceição da Barra	13,4	56
Conceição do Castelo	14,8	26
Divino de São Lourenço	16,9	11
Domingos Martins	9,8	46
Dores do Rio Preto	19,2	15
Ecoporanga	13,2	40
Fundão	18,3	48
Governador Lindenberg	10,5	14
Guaçuí	16,8	72
Guarapari	13,6	244
Ibatiba	14,6	57
Ibiraçu	16,8	27
Ibitirama	15,3	22
Iconha	11,3	15
Irupi	17,0	32
Itaguaçu	11,2	17
Itapemirim	14,5	91
Itarana	9,7	11
Lúna	16,0	53
Jaguaré	17,6	90

Continua

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

Anexo 4 – Nascidos Vivos de mães adolescentes, Municípios do ES, 2020

Continuação

Municípios	%	Números absolutos
Jerônimo Monteiro	8,2	10
João Neiva	8,0	15
Laranja da Terra	7,7	8
Linhares	14,0	360
Mantenópolis	14,9	27
Marataizes	15,1	89
Marechal Floriano	16,3	33
Marilândia	10,5	16
Mimoso do Sul	15,3	44
Montanha	19,4	54
Mucurici	19,7	15
Muniz Freire	11,3	27
Muqui	10,7	15
Nova Venécia	14,9	106
Pancas	15,6	35
Pedro Canário	22,2	68
Pinheiros	22,4	81
Piúma	12,9	44
Ponto Belo	11,0	9
Presidente Kennedy	19,4	42
Rio Bananal	12,2	34
Rio Novo do Sul	13,8	18
Santa Leopoldina	12,1	15
Santa Maria de Jetibá	10,5	67
Santa Teresa	11,2	34
São Domingos do Norte	11,7	12
São Gabriel da Palha	15,9	75
São José do Calçado	18,8	22
São Mateus	13,5	259
São Roque do Canaã	9,3	10
Serra	11,8	896
Sooretama	17,8	80
Vargem Alta	14,6	36
Venda Nova do Imigrante	11,4	38
Viana	14,0	147
Vila Pavão	15,5	16
Vila Valério	18,0	41
Vila Velha	10,2	639
Vitória	9,2	385

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - SESA
Elaboração: IJSN- Coordenação de Estudos Sociais (CES)

**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria de Economia e Planejamento



Instituto Jones dos Santos Neves
www.ijsn.es.gov.br